



كلية الآداب
قسم الدراسات السكانية

الوعي بالصحة الإيجابية لدى العاملين بجامعة المنيا دراسة ميدانية مقارنة

إعداد
محمد منصور صابر

1444هـ/2023م

شكر وتقدير



الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, يتقدم الطالب محمد منصور صابر بمقرر حلقات البحث بخالص الشكر و العرفان للاساتذة الافاضل علي مجهوداتهم العظيمة و توجيههم لي في مادة حلقات البحث , كما اتقدم بخالص الشكر و علي ما قدمو لي من توجيهات و ملاحظات بناءه نظرياً و تطبيقياً أسهمت في خروج هذا العمل للنور ، لهم مني وافر التقدير

جزاكم الله عنا خير الجزاء.....

أولاً: - فهرس الموضوعات.

الصفحات	الأبواب والفصول
1	شكر و تقدير
4 - 3	الفهرس
6 - 5	المقدمة
26 - 7	الباب الأول: - الدراسة النظرية
14 - 8	الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
8	قضية الدراسة
9	أهمية الدراسة
9	أهداف الدراسة
10	تساؤلات الدراسة
11 - 10	مفاهيم الدراسة
15 - 12	النظريات الموجهة للدراسة
16	منهجية الدراسة
22 - 17	الفصل الثاني : الدراسات السابقة.
23	التعقيب
46 - 24	الباب الثاني: - الدراسة التطبيقية
44 - 25	الفصل الاول : تحليل وتفسير البيانات
46 - 45	الفصل الثاني : أولاً: نتائج الدراسة ثانياً: توصيات الدراسة
48 - 47	مراجع الدراسة
64 - 49	الملاحق - ملحق رقم (1) استمارة الاستبيان بالمقابلة. - ملحق رقم (2) قائمة جداول التوزيع العدد والنسبي لمفردات متغيرات الدراسة.

ثانياً: - فهرس الأشكال البيانية و الجداول

الصفحة	عنوان الشكل
29 - 25	المتغيرات المرتبطة بالبيانات الشخصية
40 - 30	المتغيرات المرتبطة بالصحة الانجابية
30	التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً للوعي بالصحة الانجابية
30	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتعريف الصحة الانجابية عند المبحوث
31	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمصدر تحصيل البيانات حول الصحة الانجابية
31	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لوعيهم بخدمات الصحة الانجابية التي تقدمها وزارة الصحة
32	التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً للعلاقة بين مستوى التعليم و تشكيل الوعي بالصحة الانجابية
32	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لوجود صعوبات في تلقي خدمات الصحة الانجابية
33	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتمثيل العادات و التقاليد عائق في تلقي خدمات الصحة الانجابية
33	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لاختلاف مستوى الوعي بين الذكور و الاناث
34	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمدي وعي المبحوثين بوجود فحص طبي قبل الزواج
34	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للفحوصات الطبية الفعلية قبل الزواج
35	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتأييد المبحوثين للزواج المبكر
35	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للسن المناسب للزواج عند الذكور
36	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للسن المناسب للزواج عند الاناث
36	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعمر المبحوثين عند الزواج
37	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعدد الاطفال عند المبحوثين
37	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعدد الاطفال المناسب للأسرة من وجهة نظر المبحوث
38	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للسن المناسب للانجاب
38	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتأييد استخدام وسائل تنظيم الاسرة
39	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الاسرة
39	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لقرار تنظيم الاسرة
40	التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للوعي بالامراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل
43 - 41	الجداول و الاشكال البيانية لبعض المتغيرات المركبة
44	اختبار كاي للاستقلالية بين الدرجة الوظيفية و الوعي بالصحة الانجابية لدي عينة الدراسة (Chi)
44	اختبار التباين بين الحالة التعليمية و الوعي بالصحة الانجابية لدي عينة الدراسة (ANOVA)

مقدمة الدراسة: -

شكلت قضايا الصحة في العقد الاخير مركز اهتمام خطط التنمية والمشاريع التطويرية في الاقتصاد والاجتماع في جميع انحاء العالم ويعود ذلك لتشابك ابعادها وترابط النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والموارد البيئية. ولقد برز هذا الاهتمام في المؤتمرات الدولية الاخيرة , لاسيما المؤتمر الدولي الاخير الذي عقد في القاهرة سنة 1994م الذي تمحور اهتمامه حول الصحة والتنمية المستدامة فجاء فيه ان لكل انسان الحق في التمتع باعلي مستويات ممكنة من الصحة البدنية والعقلية وعلي الدول ان تتخذ كل التدابير اللازمة علي اساس المساواة بين الرجل والمرأة والحصول علي خدمات الصحة الانجابية والصحة الجنسية ومكافحة فيروس نقص المناعة , كما اولي اهتماما بالغاً لعنصر الصحة الجنسية سواء للمراهقين او الشباب بصفة عامة , اذا يعتبرون العمود الاساسي للمجتمع وهذا من خلال توفير المراكز الصحية التي تتضمن الرعاية والثقافة الصحية اللازمة لهم لبناء شباب قوي وسليم , وبذلك نحصل علي صحة الاسرة التي بدورها تنعكس ايجابيا علي صحة المجتمع ووقايته من الامراض المختلفة التي تؤثر علي نموه وتقدمه ¹.

وقد اصبحت الصحة الانجابية واحده من اهم وسائل النهوض بصحة الفرد والمجتمع, فالانجاب يعني انتاج أطفال اصحاء , وذلك يتطلب بالتبعية آباء وامهات اصحاء مقابل قطع نتاج ماتلقياه من رعايه صحيه تمتد عبر مراحل الطفوله مروراً بالمراهقه وليس فقط ما قبل الزواج , والثقافة الانجابية ليست فقط مجرد اكتسابا للمعلومات , وانما تشمل بناء وتعديل السلوكيات والانجاب , كما لا تعني بمرحلة عمرية بعينها اذ تعد مطلبا حيويًا للجميع صغارا وكبارا , كما لا تقتصر على جنس دون الاخر فهي ضرورية للذكور والاناث على حد سواء ².

لذا فإن الوعي السكاني احد الركائز التي تتجدد من خلالها المسؤوليات الانجابية او إن شئت فقل أن كليهما (الوعي السكاني والمسؤولية الانجابية) وجهان لتشخيص حاله القضية السكانية التي باتت قضية قوميه لا يستطيع ان ينسلخ من مسؤوليتها الافراد او الجماعات او المجتمعات المحلية في ظل المسؤوليات الفردية والاجتماعية والمدنية بل والأخلاقية التي تفرضها علينا التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية علي الصعيد القومي. والوقوف علي قضية المسؤولية الانجابية ومدي تأثيرها بالوعي السكاني يتوجب علينا قياس مدي الثبات او التغير الذي يحدث لكليهما بين الاجيال وداخل الجيل الواحد لتتضح لنا القناه الرابطة الفاصلة عمريا زمانيا بين افكار ومعتقدات جيلين متباينين بالمجتمع

عبد المجيد احمد هندي ، الوعي السكاني و المسؤولية الانجابية : دراسة ميدانية مقارنة عبر الاجيال في المجتمع الريفي ، مجلة البحث العلمي ¹ في الاداب يوليو 2022 ، ع23 ، ج6 ، ص 116-157
2 عائشة شعبان ، الوعي بثقافة الصحة الانجابية في الاسرة المصرية دراسة ميدانية بمدينة أسبوط ، المجلة العلمية لكلية الاداب ، ملحق العدد 79 ، يوليو 2021م

خاصه وان قضيه المسؤولية الإنجابية تعد واحده من اكثر الاطر التي ربما تتجلى فيها الفجوة بين الاجيال بوضوح باعتبار ان المسؤولية الإنجابية تنبع في الاساس من المواطن المتزوج القادر على ممارسة الحقوق والواجبات وتحمل المسؤوليات ذات الصلة ولهذا تتبني الدراسة التي يمكن ان تشكل لنا ضروب الوعي السكاني لتلك الاجيال وداخل الجيل الواحد وتنتج قدرا من المسؤولية الإنجابية التي ربما تتفاوت في المعرفة والادوار والممارسات بين كلا الجيلين.

الباب الأول:
الدراسة النظرية

الفصل الاول

اولا قضية الدراسة:

ان صحه الفرد في المجتمع هي الغاية التي يسعى لتحقيقها المخططون لان التنمية الصحية اساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة الإيجابية هي انعكاس للصحة خلال مراحل الحياه البشرية منذ الطفولة وحتى الشيخوخة كما انها اضافه للحالة الصحية للمرأة والرجل حتى بعد الانجاب لذا فالوعي بالصحة الإيجابية واهميتها من شأنه ان يساعد الزوجين على اتخاذ بعض القرارات المهمة في حياتهم مثل تحديد الفترة الزمنية بين كل حمل واخر مع الاخذ في الاعتبار عمر المرأة عند الحمل وظروف الأسرة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويتمثل السلوك الانجابي الصحيح في تجنب السلوكيات الخاطئة وزيادة مستوى الوعي. ويرتبط المستوى التعليمي ومستوى الفقر ارتباطا وثيقا بالصحة .

تهدف الصحه الانجابيه للحصول حياه جنسيه مسئوله ومرضيّه واكثر امانا وإعطاء الافراد حريه الاختيار في اختيار التوقيت المناسب لهم للانجاب او عدم الانجاب وأيضا ضروره واهميه وسائل تحديد النسل وملائمه كل وسيله من امراه الى أخرى وتجنب المرض او الاعاقه وأيضا تأمين رعايه صحيه جيده والتنبؤ بالمشاكل التي قد تحدث للجنين او الام خلال فترة الحمل وبعد الولادة والتغذية المناسبه وتجنب الامراض والاجهاض ومضاعفاته وتجنب المخاطر المرتبطه بالحمل في سن المراهقه والمخاطر المرتفعه بالاصابه بفيروس نقص المناعه المكتسبه وغيره من الامراض التي قد تنتقل جنسيا , وكيفية الحفاظ على التوازن الجسدي والفكري وتجنب العنف الجنسي وكيفية التعامل مع المواقف المشابهه.

فقد اشار المسح الديموغرافي الى ان النساء غير المتعلّمات التي يعشن تحت خط الفقر ينجبن عددا اكبر من الاطفال. وتمثل الصحة الإيجابية والجنسية 20 ٪ من العبء العالمي لسوء الصحة بالنسبة للمرأة و 14 ٪ بالنسبة للرجال حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2008 . كما تكمن مشكله ضعف الوعي الانجابي لدى الذكور والاناث في مختلف المجتمعات خاصه المجتمعات الشرقية والعربية لبعض الامور الدينية حيث يحرص بعض رجال الدين على منع مصطلح تحديد او ضبط النسل لما يخالف بعد العقائد او الشرائع كما حدث مع العالم (مالّتس) عندما تحدث عن ضرورة ضبط النسل ونشر الوعي لدى الازواج بخصوص الصحة الإيجابية حيث قامت الكنيسة والرجال الدين بالهجوم عليه واتهامه بنشر الفسق والدعوة الى الفجور . و لهذا تحاول هذه الدراسة معرفة مدى الوعي بالصحة الإيجابية و الاقبال علي تلقي خدماتها بين الذكور و الاناث العاملين بجامعة المنيا. و بناء على ما سبق تتضح قضية الدراسة في محاولة استكشاف مدى الوعي بالصحة الانجابية لدى العاملين بجامعة المنيا في الكليات النظرية و الكليات التطبيقية و مدى تأثير وعيهم على سلوكهم الانجابي .

ثانيا: أهمية الدراسة

الأهمية النظرية

- ندرة الابحاث والدراسات التي تناولت مستوى الوعي بالصحة الانجابية.
- تسعى هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على وعى المجتمع بالصحة الإنجابية.
- التأكد من صحة بعض الفرضيات و النظريات حول هذه القضية

الأهمية التطبيقية.

- محاولة التوصل لنتائج و توصيات فعالة تسهم في تعزيز الوعي بالصحة الانجابية .
- توجيه انتباه متخذي القرار نحو موضوعات الصحة الانجابية لاهميتها و انعكاساتها الايجابية علي صحة الانسان و سلوكياتهم.

ثالثا: أهداف الدراسة:

- الهدف الرئيسي للدراسة: التعرف علي مدى وعي العاملين بجامعة المنيا بقضايا الصحة الانجابية .

الأهداف الفرعية للدراسة:

- التعرف علي فروق مستويات الوعي بالصحة الإنجابية بين الكليات النظرية والتطبيقية .
- مستوى معرفه الإناث والذكور بتنظيم الأسرة.

رابعا: تساؤلات الدراسة

والدراسة تنطلق من تساؤل رئيسي: -

ما مدى وعى العاملين بجامعة المنيا بقضايا الصحة الانجابية ؟

ويتفرع من ذلك تساؤلات فرعية: -

- ما درجة وعي مجتمع البحث بقضايا الصحة الإنجابية؟
- هل ثمة فروق في مستويات الوعي الانجابي لدى العاملين بجامعة المنيا ؟
- هل يؤثر الوعي الإنجابي لدى العاملين في تحديد سلوكهم الانجابي؟
- إلى أي مدى يقبل مجتمع البحث على خدمات الصحة الإنجابية؟
- هل يوجد تباين واضح في مستوى الوعي الإنجابي لدى العاملين في جامعة المنيا؟

خامسا: مفاهيم الدراسة

جاءت مفاهيم الدراسة في مفهومين رئيسيين (الوعي ، الصحة الانجابية)

مفهوم الوعي لغة: هو الفهم وسلامة الادراك في وعي الوعي وحفظ القلب لشيء وعي الشيء .
والحديث يكون وعيا حفظه " وفهمه .

. ويعرف قاموس كامبريدج الوعي بأنه حاله فهم وإدراك شيء ما .

. "ويعرفه قاموس اكسفورد الوعي بأنه " حالة دراية المرء بمحيطه والانسجام له .

. وعرف ماركس: الوعي بأنه عبارة عن بناء تدريجي تندرج تحته كافة الأنشطة الإنسانية

مفهوم الوعي اصطلاحيا: هو ادراك الفرد لنفسه والبيئة المحيطة فهو حصاد ادراك الناس

وتصور لهم للعالم المحيط بهم فالوعي سلوك اجتماعي يتم الادراك العميق من جانب الفرد او

الجماعة وترجمة هذا الادراك علي نمط من السلوك الفعلي وتوفر البصيرة الاجتماعية عند الفرد

او الجماعة لتتمكن من الالمام الكافي بالأبعاد الاجتماعية والتنبؤ ما قد يترتب عليها في المواقف

المختلف.

ويشير مفهوم الوعي الي: معرفة الفرد بوجود شيء ما وان الوعي العام للفرد يقصد به الافكار

والتقافات والتطلعات الي مستوي ناضج يمكن معه جعل ان الوعي العام قد استكمل معلومات

الاساسية ويرتبط الوعي العام ارتباطا وثيقا بالرأي العام وكلما كان الرأي العام قويا وناضجا ارتقي

الي مستوي الوعي العام

ويشير الوعي ايضا: الي انه المعرفة والادراك والتقدير والشعور لمجال معين مما يؤثر في توجيه

سلوك الفرد نحو هذا المجال¹.

الصحة: وقد عرفت منظمه الصحة العالمية (WHO) على انها حاله من اكتمال السلامة البدنية

والعقلية والاجتماعية لا مجرد انعدام المرض او العجز².

عائشة شعبان علي ابراهيم ، الوعي بثقافة الصحة الانجابية في الاسرة المصرية ، دراسة ميدانية بمدينة أسبوط ، المجلة العلمية بجامعة أسبوط¹
كلية الاداب ، مجلد 24 ، ص 70 ، 2021

ساره مسلم هادي النادر ، التحليل الجغرافي لمؤشرات الصحة الإيجابية في محافظه كربلا المقدسة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 2022²

مفهوم الوعي الصحي "Health Awareness"

الوعي الصحي هو عبارة عن وعي معرفي بالحقائق والمفاهيم الصحية وينتجه عنه وعي وجداني يظهر علي هيئة اتجاهات وميول ايجابية لبعض القضايا الصحية المناسبة للمرحلة مؤديا في النهاية الي وعي تطبيقي من خلال ممارسات صحية ايجابية عن قصد نتيجة الفهم والاقناع وتحولها الي عادات تمارس بلا شعور او تفكير¹.

مفهوم الصحة الإنجابية لغويا :

قدرة الأفراد علي الحصول علي حياة جنسية مرضية ومأمونة ، وقدرتهم علي الإنجاب وحريرتهم .
في تقرير موعده وتواتره .

مفهوم الصحة الإنجابية اصطلاحيا :

وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية: وهي الوصول إلي حالة اكتمال السلامة البدنية والنفسية والتعليمية والاجتماعية وليست مجرد الخلو من المرض أو الاعاقة² .

ويشير مفهوم الصحة الانجابية :

هي حالة سلامة كاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا في الامور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته وليست مجرد السلامة من المرض والاعاقة وهذا يعني ان الصحة الجنسية الايجابية وهي تتمتع بالمخاطب بهذا البند_ اي كان بغض النظر عن حالتها الزوجية او توجهه الجنسي بكامل المعافاة في كل ما يخص جهازه التناسلي ووظائفه وعمليات³.

وعرفت منظمة الصحة العالمية "الصحة الإنجابية" علي انها الوصول الي حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الامور ذات العلاقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملياته وليس فقط الخلو من الامراض والاعاقة وهي تعد جزءا اساسيا من الصحة العامة وتعكس المستوي الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب⁴.

الانجاب (Childbearing)

لغويا : الانجاب مصدر للفعل انجب ويقال انجبت المرأة اي ولدت مولوداً.

اصطلاحيا: الانجاب كلمه تعني العدد الفعلي لحالات الولادة عند كل امرأة.

عبدالمجيد احمد هندي.(2022) ، الوعي السكاني والمسؤولية الانجابية :دراسة ميزانية مقارنه عبر الأجيال بالمجتمع الريفي ،مجلة البحث العلمي في الآداب ، 23ع، ج 6

محمد صالح مسعي احمد ، ثقافة الصحة الانجابية لدي الطالب الجامعي ، 2019 ²
كتاب الصحة الايجابية ، قسم الصحة العامة و الطب الوقائي و الاجتماعي ، كلية الطب جامعة المنيا ، 2022 ³
منظمة الصحة العالمية ، تعزيز النظم الصحية ، معجم جنيف ، 2011 ⁴

سادسا النظريات :

فيما يلي عرض لبعض النظريات التي تتبناها الدراسة الراهنة :

نظرية التشكيل البنائي وإعادة انتاج الوعي:

يري " جيدنز " A.Giddns ان التشابك المستمر بين الوعي الصحى والسلوك الإنجابي وهو الذي يشكل النظام الاجتماعي والذي من خلاله يتم الحفاظ علي النظام الاجتماعي أو المساهمة في التغيير أو التحول الاجتماعي ،ووفقا لذلك فإن السلوك الإنجابي يمهّد الطريق نحو الحفاظ علي النظام الاجتماعي أو تغييره من خلال عاملي "القواعد" و"الموارد" وحيث يتصور "جيدنز" أن تلك القواعد دينامية ، وتشكل أساس التفاعل اليومي ،وتلك القواعد أما يتم الحفاظ عليها (إعادة إنتاجها) أو تغييرها أي (تحويل شكلها). ويعترف "جيدنز" بان للأفراد والجماعات القدرة الفريدة علي التأمل في افعالهم ، وعلي تغيير سلوكهم من خلال اليات وهي :

- ١-المعرفة: أطلق عليها المعرفة المشتركة التي تعد بمثابة لمخزون لبناء الفعل الاجتماعي والتي يستخدمها الفاعلون وهم علي وعي لتوجيه تفاعلاتهم نحو اهداف محددة.
- ٢-الوعي العلمي: هو المهارة الاجتماعية في الفعل الاجتماعي وانتقاء اساليب لاتخاذ القرارات التي تؤدي إلي إعادة الإنتاج أو التغيير الاجتماعي.
- 3-الوعي التعبيري: يظهر في سياق المناقشات الاجتماعية.¹

نظرية الوعي والفعل ل "شوتز" :

قدم "شوتز" نظريته حول الوعي والفعل ، وفيها طرح لوعي الفاعلين ،اي الطريقة التي يصوغ بها الناس الواقع الاجتماعي ،وعلاقه ذلك الوعي بفكر الفرد وفعله ،حيث يرى أن الفاعلين إما أن يكونوا أحرارا احيانا علي الاقل في صوغ اي واقع يريدونه ،او مقيدين - وحيانا ومحكومين - بمعايير المجتمع وقيمه في ضوء الواقع الثقافي .

ويلاحظ أن "شوتز" يفسر الفعل الإنساني في سياق معاني الفاعلين ووعيهم بدلا من كونه محصلة مؤثرات "خارجية" فتحدد الخبرات والمعاني المشتركة في جماعة ما ،وكيفية ارتباط هذه المعاني بالثقافة الأشمل يعد الإطار المرجعي للجماعات ومع مرور السنين ينتج ذلك الوعي رصيذا مشتركا من المعاني التي تمكن أعضاءها بدرجة أو بأخرى من أن يفهموا بعضهم بعضا ويتوقعوا أفعالهم .²

¹ عبدالمجيد احمد هندي.(2022) ،الوعي السكاني والمسؤولية الانجابية :دراسة ميزانية مقارنه عبر الأجيال بالمجتمع الريفي ،مجلة البحث العلمي في الآداب ،23ع، ج 6
² مرجع سابق

نظرية التكلفة :

أهم أفكار النظرية:

- الناس يتصرفون بحكمة وعقلانية نحو مسألة الانجاب، ويعدون حساباتهم الأولية بخصوص عدد الاولاد، والتكلفة الناجمة عن الانجاب.

- المنافع المستمدة من ولادة طفل جديد:1: منفعة نفسية: يعد الطفل مصدر سعادة وفرحة لأسرته، الذي جاء بعد طول انتظار، أو جاء بعد عدة أطفال من الجنس الآخر:

1- منفعة مادية: يعد الطفل في المستقبل عامل إنتاج في الاسرة.

2- منفعة متوقعة: يتوقع من الابن في المستقبل أن يساعد والديه ورعايتهم في شيخوختهم.

- التكلفة الاضافية الناجمة عن ولادة طفل جديد:

1- تكلفة مباشرة: وجود طفل جديد يعني مزيدا من النفقات الاسرة، حتى يشتد عوده ويكبر ويعتمد على نفسه، ويقدر على إعالة نفسه.

2- تكلفة غير مباشرة: تضيق فرص عمل على المرأة خارج المنزل؛ بسبب انشغالها ف تربية ورعاية الطفل الجديد¹.

المادية التاريخية والوعى الاجتماعي:

يعد الاتجاه المادي التاريخي من أكثر الاتجاهات النظرية اهتماما بقضايا الوعى، فقد قدم "ماركس" رؤية خاصة لقضايا الوعى في إطار نظريته العامة في التاريخ ، والتي تقيد أن كل الظواهر اللاحقة للوجود إنما هي انعكاس لنتائج الوعى... وملخص القول في هذا الشأن : إن الاتجاه المادي يعد الوعى هو ما يكتسبه الإنسان من مدارك ومعارف ثقافيه مختلفة عن الحياه العامة في المجتمع ، وتفسيره الوعى في خلال ربطة بالوجود الاجتماعي، أو بالأوضاع الاجتماعية لوجود الناس أو نمط الحياه المادية التي يعيشون في ظلها² .

ربا السيد محمد ابو كميل، مستوى الوعى بمفاهيم الصحة الإنجابية لدي طلبة المرحلة الأساسية العليا في غزة، 2011¹
سليمان ،عائشة شعبان على إبراهيم، 2021، الوعى بثقافة الصحة الإنجابية في الأسرة المصرية، دراسة ميدانية بمدينة أسبوط ،المجلة العلمية
لكليه الآداب، مج. 24.

البنائية الوظيفية ودراسة الوعي:

تتضح رؤية البنائية الوظيفية وفهمها إزاء قضية الوعي الاجتماعي من خلال أبرز المفكرين السوسيولوجيه ، ومنهم: (دوركايم ، وبارسونز ، وميرتون) ويحدد جوهر تصورات دوركايم في المعارف البشرية أنها تقوم على أساس تصورات ومفاهيم عامة ، تحدد شكل هذه المعارف وطبيعتها ، وأن مثل هذه التصورات والمفاهيم ليست متأصلة في العقل البشري ، وإنما تحدد بصوره اجتماعية ، وترتبط بالحياة الاجتماعية ونشاطات الناس في المجتمع ، ويؤكد " دوركايم " أهمية المعرفة الفلسفية والعلمية ، وأن الدين هو مصدر تلك المعرفة ، ولذا يطابق دوركايم بين العقل والواقع الاجتماعي ، بينما تجاهل دوركايم ما يوجد في هذا الواقع في صراعات وتناقضات داخلية وبخاصة صراع الطبقات . أما "تالكوت بارسونز" فيحدد قضية الوعي الاجتماعي في نظريته على فكره الاختيار الإداري من جانب القائم بالفعل ، ويقصد بها قدره القائم بالفعل الاجتماعي على أن يقوم بعملية اختيار بالنسبة للعناصر القائمة في الموقف الاجتماعي الذي يوجد فيه ، وهذا الاختيار ال يعنى الحرية المطلقة ، ألن المعايير والقيم السائدة في المجتمع تؤدي دورا رئيسا في تحديد ما يختاره الفاعل؛ بحيث يمكن القول : إن الاختيارات التي يقوم بها الفاعل هي مجموعة من العناصر التي أوجدها البناء الاجتماعي أو الثقافي في المجتمع الذي يوجد به هذا الفاعل، بالإضافة إلى وجود العقل وآفاق الوعي والتوجه الذاتي لدى من يقوم بالفعل الاجتماعي¹.

التعقيب علي النظريات :

نظرية التشكيل البنائي وإعادة انتاج الوعي:

تشير هذه النظرية إلى أن المسؤولين الإنجابية للأزواج كأحد الممارسات الاجتماعية الاسريه للفعل الانساني تؤسس على الوعي المتجدد عبر المعرفة الموجه لاتخاذ القرارات العقلاني تجاه تلك المسؤوليات سواء بالذات، أو للأبناء أو للزوجات أو للمجتمع ككل، وبالتالي يلعب الوعي بالصحة الإنجابية دوراً مهماً في صحة الفرد بشكل عام.

نظرية الوعي والفعل ل "شوتز" :

تشير هذه النظرية الى علاقه الوعي بفكر الفرد وفعله حيث يرى ان اما يكون الافراد احرارا او يكونوا محكومين بمعايير المجتمع وقيمه في ضوء الواقع الثقافي وتفسير شوتز الفعل الإنساني في سياق معاني

سليمان ، عائشة شعبان على إبراهيم ، 2021 ، الوعي بثقافة الصحة الإنجابية في الأسرة المصرية، دراسة ميدانية بمدينة أسبوط ،المجلة العلمية 1
لكليه الآداب، مج. 24.

الفاعلين ووعيهم بدلا من كونه محصلة مؤثرات خارجية فتحدد الخبرات والمعاني المشتركة في جماعه ما وكيفيه ارتباطها بالثقافة.

نظرية التكلفة :

تؤكد هذه الي ان الناس يتصرفون بحكمه عقلانية نحو مساله الإنجاب ويقعدون حسابهم بخصوص عدد الأطفال التكلفة النجمة عن الانجاب مما يقلل عدد الافراد في الأسرة وذلك يساعد بحياة انجابيه افضل.

المادية التاريخية والوعى الاجتماعي:

تشير هذه النظرية الى ان الظواهر اللاحقة هي انعكاس لنتائج الوعى حيث تهتم بقضايا الوعى بشكل عام حيث ترى ان الوعى هو ما يكتسبه الإنسان من مدارك ومعارف ثقافيه وان الوعى يرتبط بالأوضاع الاجتماعية ونمط الحياة المادية التي يعيشونها

البنائية الوظيفية ودراسة الوعى:

تؤكد هذه النظرية الى ان المعارف والمفاهيم البشرية انها ليست متأصلة في العقل البشري وانما ترتبط بالوعى الناتج عن نشاط الناس في الحياه الاجتماعية، وان الاختيارات التي يقوم بها الفاعل هي مجموعة من العناصر التي أوجدها البناء الاجتماعي أو الثقافي في المجتمع الذي يوجد به هذا الفاعل، بالإضافة إلى وجود العقل وآفاق الوعى والتوجه الذاتي لدى من يقوم بالفعل الاجتماعي.

منهجية وادوات الدراسة

المنهج :

- منهج المسح الاجتماعي بالعينة.
- المنهج المقارن : لقياس فروق الوعي بالصحة الإنجابية بين العاملين بجامعة المنيا في كلية نظرية و كلية تطبيقية .

ادوات الدراسة :

استخدمت الدراسة استمارة استبيان بالمقابلة : حيث اشتملت علي عدد من الاسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة (الوعي بالصحة الانجابية) , بغرض عرضها علي افراد العينة.

مجالات الدراسة:

المجال المكاني:

طبقت الدراسة ميدانيا بجامعة المنيا.

المجال الزمني:

تمت الدراسة خلال شهر فبراير حتى شهر مايو ٢٠٢٣م.

المجال البشري:

طبقت الدراسة على العاملين المتزوجين بجامعة المنيا.

نوع العينة :

عينة عشوائية بسيطة لضمان فرصة ظهور كل المبحوثين من ضمن العينة.

التحليل الاحصائي:

- تم استخدام الجداول البسيطة والمركبة في الاحصاء الوصفي .
- تم الاعتماد علي النسب و المعدلات في وصف متغيرات الدراسة لقوة دلالتها الوصفية.
- تم الاعتماد علي الاشكال البيانية في وصف المتغيرات البسيطة و المركبة .
- تم الاعتماد علي كا للاستقلالية (Chi) لاستكشاف وجود علاقة و التباين (ANOVA) لقياس قوة الارتباط بينهم .
- تم الاعتماد علي برنامج (Excel) و برنامج (SPSS) في تفريغ الاستمارات الكترونياً و تم أيضا تفريغ الاستمارات يدوياً.
- تم الاعتماد علي برنامج Statistical Package for Social Sciences (SPSS) اصدار (28) و هي احدث النسخ المتاحة حالياً.

الفصل الثاني

الدراسات السابقة :

مقدمه :

يتناول هذا الفصل بالشرح والتحليل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الوعي بالصحة الإنجابية. وتعدد الدراسات السابقة من الاركان الأساسية في البحث والتي تلحق بالاطار النظري. و تتكون من الدراسات والابحاث التي تناولت الموضوع الذي يقوم البحث بدراسته، وتلعب الدراسات دورا كبيرا في اعطاء الباحث فكره عامة عن البحث الذي يقوم به وعن مراحل تطوره والدراسة السابقة هي المكون الثاني من مكونات الإطار النظري للدراسة.

وفيما يلي عرض للدراسات السابقة علي المستويين القومي و الدولي.

اولا الدراسات على المستوى القومي:

دراسة (احمد سيد خليل، راضي عبد المجيد طه ، 1999م) تحت عنوان الوعي السكاني لدي طلاب كلية التربية بأسوان ؛ دراسة ميدانية .

تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي وعي الطلاب في كلية بجامعة اسوان بالمعارف المتعلقة بالسكان وقضاياهم وذلك فتي ضوء المتغيرات المتصلة بمكان الاقامة والجنس والتخصص. تقتصر عينة الدراسة علي طلاب كلية التربية بجامعة اسوان مع مراعاة التخصص ومكان الاقامة والجنس، استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي حيث يتم من خلاله تحليل ومناقشة ابعاد القضايا السكانية عن طريق استمارة استبيان، وكانت أبرز نتائج الدراسة :لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين التخصصات السابقة في المحاور الاتية :

• اتجاهات النمو السكاني

• العوامل المؤثرة علي النمو السكاني

• مشكلات الزيادة السكانية.¹

1. احمد سيد خليل ؛ راضي عبد المجيد طه ؛ الوعي السكاني لدي طلاب كلية التربية جامعة اسوان ؛ دراسة ميدانية ؛ جامعة طنطا، عام 1999

دراسة (عبد المعين هندي ، 2005م) تحت عنوان "دور التعليم في تنمية الوعي بالصحة الانجابية لدى المرأة بصعيد مصر " دراسة ميدانية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الصحة الانجابية وابعادها ، ومدى تأثير العادات والتقاليد السائدة بصعيد مصر على الصحة الانجابية.

تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينه قوامها (٧٢٠) امرأة من محافظتي سوهاج واسيوط ، وقد شملت العينة مؤهلات فوق عليا (١٥٠) مؤهلات عليا (٢٧٠) ومؤهلات متوسطة (٢٠٠) وغير مؤهلات (١٠٠)، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي ؛

وكانت أبرز نتائج الدراسة :

- أتضح ان تأثير التعليم ضعيف في توصيل المعارف والثقافة في مجال الصحة الانجابية ، كما ان معظم الثقافة مأخوذة من الاعلام.
- التعليم لم يؤد دورا فعالا في تنميه الوعي لدى المرأة في صعيد مصر بالصحة الانجابية وان العادات والتقاليد اقوى فاعلية وتأثير من التعليم.
- التعليم به قصور كبير في توصيل المعرفة اللازمة في مجال الصحة الانجابية.
- هناك قصور في تقديم خدمات الصحة الانجابية ¹.

دراسة (نجوي عبدالرحمن حسن ، 2007) تحت عنوان محددات السلوك الانجاب للريفيات بمحافظة المنوفية و أسيوط .

استهدفت هذه الدراسة تحديد مستويات السلوك الإنجابي للريفيات بمحافظة المنوفية واسيوط وتحديد الفروق المعنوية فيما يتعلق بسلوكهن الإنجابي والتعرف على علاقته المتغيرات، المستقلة المدرسة بدرجات السلوك الانجابي وتحديد المساهمة النسبية لبعض تلك المتغيرات المستقلة في تفسير التباين والحدث في درجات السلوك الانجاب والتعرف على مصادر معلومات الريفيات عن وسائل تنظيم الأسرة وقد بلغ حجم العينة بالمحافظتين (١٥٠) مبحثا بكل محافظه وقد استخدمت الدراسة الاستبيان بالمقابلة وقد توصلت الدراسة لنتائج التآليه: ارتفاع نسبة المبحوثات اللي في يد محافظه المنوفية في الفئه المنخفضة في السلوك الإنجابي بنسبه 45% بينما ارتفعت نسبة المبحوثات الريفيات بمحافظه اسيوط في فالفئه المتوسطة للسلوك الانجابي 60%².

عبد المعين سعد الدين هندي ، دور التعليم في تنمية الوعي بالصحة الانجابية لدى المرأة بصعيد مصر دراسه ميدانية ، المجلة التربوية ، ع ١ . ٢١ ، يناير ٢٠٠٥م

نجوى عبد الرحمن حسن، دراسة مقارنة لمحدده السلوك الانجابي للريفيات بمحافظه المنوفية واسيوط، جامعه المنوفية، 2007 ²

دراسة (ايمان محمد الصياد ، 2017) تحت عنوان "المحددات الاجتماعية للسلوك الإنجابي للمرأة الريفية" دراسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ .

انطلقت هذه الدراسة من هدف رئيسي يتمثل في دراسة وتحليل تأثير المحددات الاجتماعية على السلوك الإنجابي للمرأة الجنسية بمحافظه كفر الشيخ، وتمثلت فروض الدراسة في الاتي:

1- الفرض الاول: توجد علاقة ارتباطيه بين السلوك الانجاب للزوجات الريفيات كمتغير تابع وبين المحادثات الاجتماعية للسلوك الايجابي للمرأة الريفية.

2- الفرض الثاني: يسهم كل متغير مستقل من المتغيرات "المحددات الاجتماعية" اسهاما معنويا فريدا في تفسير جزءا من التباين في درجات المتغير التابع (السلوك الانجابي للزوجات الريفيات)، واستعانة الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي بطريقه المسح الاجتماعي العينة، واعتمد الدراسة في جمع البيانات بصورة اساسيه على استمارة الاستبيان بالمقابلة المقننة وكان من اهم نتائج الدراسة: ١- ان ثمة تعدد وتباين في المحددات الاجتماعية التي تؤثر في السلوك الانجابي في المرأة الريفية، والتي لها تأثير على سلوكهم بشكل اساسي وتحديد نمط وسلوك حياتهم وتتمثل اهمها في طول فترة الزواج، تعليم المرأة، استخدامها لوسائل تنظيم الأسرة، الوعي بالصحة الإنجابية، الرغبة في انجاب مزيد من الاطفال¹.

دراسة (امل ابراهيم عبده سليمان ، 2018) تحت عنوان " وعي الشباب الجامعي بقضايا الصحة الانجابية " .

تحديد درجة وعي الشباب بالصحة الانجابية للمتزوجين و دراسة مصادر المعلومات التي يستقر الشباب منها معارفهم من الصحة الإنجابية، وتحديد درجة وعي الشباب بالتغيرات الجسمية التي تحدث من الطفولة الي المراهقة، وكانت عينه الدراسة طلاب الفرقة الاولى لكافة الكليات بجامعة الفيوم وعددهم (1500) طالب، واستخدمت المنهج الكمي واستخدمت الباحثة منه طريقة المسح الاجتماعي الشامل بحيث انه من انسب المناهج ملائمة لهذه الدراسة لاتساقه مع مشكلتها واهدافها وقد استخدمت الباحثة اسلوب المسح الاجتماعي الشامل للفرقة الاولى لكافة الكليات بجامعة الفيوم، وكانت الرز نتائج الدراسة :

- عدم وعي الشباب بمخاطر التدخين وتأثير ذلك علي الصحة الانجابية.
- زياده وعي الشباب حول السن المناسب للإنجاب اول طفل حيث بلغت نسبته 74 %².

ايمان محمد الصياد، المحددات الاجتماعية للسلوك الإنجابي للمرأة الريفية دراسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، جامعه عين شمس، ¹ م(٤٥)، ٢٠١٧

² أمل ابراهيم عبده، وعي الشباب الجامعي بقضايا الصحة الإنجابية، الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين، يونيو 2018، عدد 60، ص 137_188.

دراسة (عائشة شعبان؛ 2021) تحت عنوان : الوعي بثقافة الصحة الانجابية في الأسرة المصرية دراسة ميدانية بمدينة أسيوط "

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على درجة وعي مجتمع البحث بثقافة الصحة الانجابية ورصد اتجاهاتهم وسلوكهم تجاه الممارسات الخاصة بها والوقوف على مدى اقبال الافراد على خدمات الصحة الانجابية، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها (٣٠٠ زوج وزوجة في محافظة أسيوط ، خلال شهر مارس وشهر ابريل وشهر مايو لعام ٢٠٢١م، واستخدمت الدراسة بشكل أساسي منهج المسح الاجتماعي العينة، تعد أبرز نتائج الدراسة:

- نسبة كبيرة من العينة يعرفون بأن عليهم الخضوع لفحص طبي قبل الزواج لما له من تأثير ايجابي على الصحة الانجابية.
- هناك نسبة لا بأس بها من العينة لهم دراية بالأمراض المنقولة جنسيا ولكن تلك المعرفة تنحصر في الغالب في مرض الإيدز¹.

دراسة (عبدالمجيد هندي ؛ 2022) تحت عنوان الوعي السكاني والمسؤولية الانجابية ؛ دراسة ميدانية مقارنة عبر الاجيال بالمجتمع الريفي"

استهدفت الدراسة وصف حالة الوعي والمسؤولية الانجابية لدى الازواج و الوقوف علي مدي تجانس او تغيير العلاقة بينهما عبر الاجيال، واجريت الدراسة بقرية" تل العمارنة "كأحد المجتمعات الريفية وقام الباحث بأعداد دليل الجماعة النقاش البؤرية لمناقشة مفردة من جيلي الدراسة ؛ مقياس للوعي السكاني واخر المسؤولية الايجابية كأدوات للتحليل الكمي للبيانات وطبقت الدراسة علي عينة عشوائية بسيطة قوامها (550) فرد، واعتمدت منهجيا علي طريقتي المسح الاجتماعي بالعينة المقارنة،
وابرز نتائج الدراسة:

- ثبوت صحة فرض الدراسة حيث اشارت التحليلات الي تباين اتجاهات ومعارف وإدراكات الوعي السكاني بين الجيلين وبالمثل مسؤولياتهم تجاه الامومة والامنة ورعاية الابناء بعد الانجاب وصحة الزواج الانجابية.
- هناك ارتفاع في مستويات الوعي والمسؤولية لدي الجيل يعني الي وجود تغيير بين الجيلين.

¹ عائشة شعبان ، الوعي بثقافة الصحة الانجابية في الأسرة المصرية دراسة ميدانية بمدينة أسيوط ، المطلة العلمية لكلية الآداب ، ملحق العدد ٧٩ ، يوليو ٢٠٢١م.

دراسة (نجلاء محمد احمد ؛ 2022) تحت عنوان " المتغيرات السوسيوثقافية _ اقتصادية بيئية
المؤثرة في الصحة الانجابية للمرأة دراسة مقارنة بين منطقة عشوائية واخرى حضرية"¹

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالصحة الانجابية والتعرف على مدى توافر مصادر المعرفة التي تمكن المرأة في المناطق العشوائية والحضرية من الحفاظ على صحتها الانجابية، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها (٣٠٠) زوجة بمنطقة عشوائية واخرى حضرية بمدينة سوهاج ، وذلك خلال فترة استغرقت حوالي عام ونصف ، معتمدة على استمارة استبيان كأداة للدراسة، و استخدمت الدراسة منهجي المسح الاجتماعي بالعينة ، والمنهج المقارن، وكانت اهم نتائج الدراسة:

- المعلومات المتعلقة بالصحة بصفة عامة والصحة الانجابية بصفة خاصة تم استيفاءها من وسائل الإعلام وذلك في المنطقة العشوائية.
- النساء بالمناطق الحضرية لديهم وعي كبير بالموضوعات المتعلقة بالصحة الانجابية.

¹ نجلاء محمد احمد عبد الرحمن ، المتغيرات السوسيوثقافية الاقتصادية بيئية المؤثرة في الصحة الانجابية للمرأة دراسة مقارنة بين منطقة عشوائية واخرى حضرية ،مجلة كلية الآداب ، ع(٦٤) ج (٢) ، ٢٠٢٢م.

ثانيا : الدراسات على المستوى الدولي

دراسة(محمد محمود أبو زنيد ، ٢٠٠٦ م) تحت عنوان : مفاهيم و مواقف طلاب

جامعة النجاح الوطنية في مواضيع الصحة الانجابية¹

تهدف هذه الدراسة للتعرف على مواقف ومفاهيم طلبة جامعته النجاح حول المواضيع الصحة الانجابية والجنسية وتنظيم الأسرة وتحديد أثر العديد من المتغيرات مثل الجنس والعمر والمنطقة وغيرها من المتغيرات على سلوك الطلاب في مواضيع الصحة الانجابية ، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها (400) طالب وطالبة بجامعة النجاح الوطنية وذلك خلال فترة الترم الثاني من العام الدراسي (2003 / 2004) معتمدة على استمارة استبيان كأداة للدراسة، تحليل احصائي على برنامج SPSS .

وكانت أبرز نتائج الدراسة:

-هناك 64% من عينة الدراسة يفضلون انجاب اقل من 4 اطفال .

-العمر المثالي للزواج كان ٢٠ عاما من وجهة نظر الذكور والاناث.

دراسة (فهد الصبري - سمية صالح ، ٢٠١٣) تحت عنوان :قياس وعي الشباب بأهمية

القضايا السكانية وتعداداتها المستقبلية²

تهدف الدراسة الى تحديد وقياس حجم المعرفة لدى الشباب فيما يخص القضايا السكانية وتأثيرها على التنمية وجودة الحياة، تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها (350) شاب وشابة في أمانة العاصمة ومحافظة تعز، واستخدمت الدراسة المنهج الإحصائي التحليلي لعينة عشوائية بسيطة معتمدة على استمارة استبيان، أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

• ٩٣ % من الإناث و ٨٧ % من الذكور يعرفون بشكل صحيح المقصود بالصحة الانجابية.

• ٨ % من الشباب يعرفون أن الحمل المبكر قبل ١٨ سنة لو اضرار على الأم والطفل.

¹ محمد محمود عيسى ابو زنيد ، مفاهيم ومواقف طلاب جامعته النجاح الوطنية في مواضيع الصحة الانجابية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، فلسطين ، ٢٠٠٦م

² فهد الصبري _ سمية صالح ، قياس وعي الشباب بأهمية القضايا السكانية وتعداداتها المستقبلية ، عام 2013 ، من ص : 5ص. 85

ثالثاً: التعقيب

من خلال عرض الدراسات السابقة توصل الباحث لمجموعه من النقاط المهمة وهي كالآتي:

تشابهت دراسة احمد سيد خليل ، راضي عبدالمجيد طه مع دراسته عائشه شعبان 2022 ودراسة عبد المعين هندي 2005 ودراسة فهد الصبري ، سميه صالح 2013 ودراسة محمد محمود ابوزنيد 2006 في هدف واحد وهو التعرف علي درجه وعي المجتمع بالصحة الانجابيه وتأثيراتها المختلفه باستثناء دراسة نجلاء عبدالرحمن 2022 ودراسة دكتور عبدالمجيد احمد هندي 2022 حيث هدفت الأولى الي التعرف علي المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالصحة الانجابيه والتعرف علي مدي توافر معرفه لدي المرأه بخصوص الصحة الانجابية ، أما الثانيه فهدفت الي وصف حاله الوعي والمسئولية الانجابية لدي الأزواج والوقوف علي مدي تجانس أو تغير علاقه بينهم علي مدي الأجيال .

كما اتفقت دراسة نجلاء عبدالرحمن وعائشه شعبان وعبدالمجيد احمد هندي في استخدام منهج واحد وهو منهج المسح الاجتماعي بالعينة ، في حين استخدمت دراسة عبد المعين هندي ودراسة احمد سيد خليل وأحمد أبو الجمائل المنهج الوصفي اما دراسة محمد محمود ابو زنيد ودراسة فهد الصبري اعتمدوا علي منهج إحصائي تحليلي .

كما تشابهت الدراسة السابقة في استخدام اداه واحده وهي استماره الاستبيان مع عدا دراسته عبد المجيد احمد هندي حيث استخدم مقياس للوعي السكاني ، أما في العينة فقد اتفقت دراسة عائشه عبدالرحمن وفهد الصبري ومحمد محمود ابو زنيد في استخدام عينه من الذكور والإناث متزوجين أو غير متزوجين ، بينما اختلفت عنهم دراسة عبد المعين هندي ونجلاء عبدالرحمن في استخدام عينه من الزوجات فقط .

اما بالنسبه للدراسة الراهنه ، فقد تشابهت مع الدراسات السابقة في أن تحاول الدراسة الراهنه سد الفجوه البحثية المتعلقة بالوعي بالصحة الانجابية لدي الذكور والإناث ، فقد تشابهت مع الدراسات السابقة في الأداه استماره الاستبيان والعينه الذكور و الاناث متزوجين والهدف تحديد مستوي الوعي بالصحة الانجابية ، إلا أنها اختلفت في استخدام منهج المسح الاجتماعي بالاضافة الي المنهج المقارن ، ومن هنا تأتي القوة.

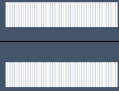
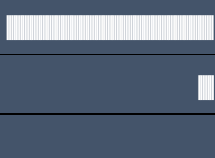
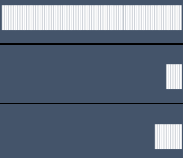


الباب الثاني

الدراسة التطبيقية

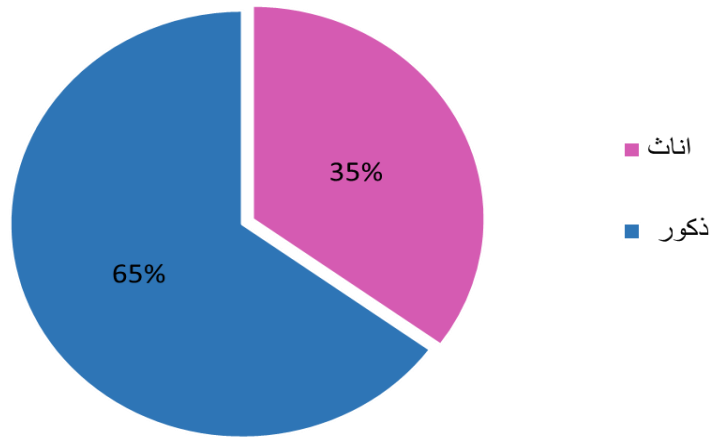
الباب الثاني: - الدراسة التطبيقية.

اولا المتغيرات المرتبطة بالبيانات الشخصية

التمثيل البياني	النسبة المئوية	العدد	البيانات الشخصية	
	65%	26	ذكر	الجنس
	35%	14	انثي	
	10%	4	20:29	العمر
	42.5%	17	30:39	
	22.5%	9	40:49	
	25%	10	50 فأكثر	
	50%	20	حضر	محل الإقامة
	50%	20	ريف	
	80%	32	ملك	نوع المسكن
	20%	8	إيجار	
	92.5%	37	متزوج/ة	الحالة الاجتماعية
	7.5%	3	مطلق/ة	
	0%	0	ارمل/ة	
	40%	16	متوسط	الحالة التعليمية
	10%	4	فوق متوسط	
	30%	12	جامعي	
	20%	8	فوق جامعي	
	80%	32	موظف اداري	الدرجة الوظيفية
	7.5%	3	هيئة مساعدة	
	12.5%	5	عضو هيئة تدريس	
	35%	14	اقل من 3000	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	45%	18	من 3000 الي 5000	
	15%	6	من 5000 الي 8000	
	5%	2	أكثر من 8000	

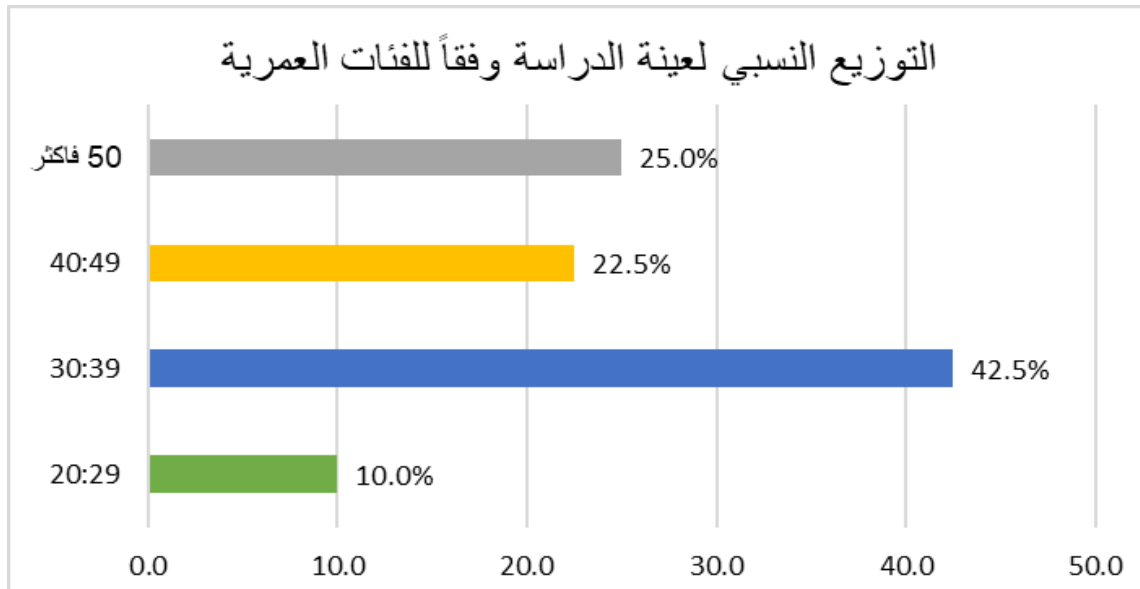
شكل رقم (1)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للنوع



يوضح الشكل رقم (1) التوزيع النسبي للعاملين بجامعة المنيا وفقاً لنسبة النوع حيث يشير الرسم البياني الى ان الحصة الاكبر كانت من نصيب الذكور بنسبة 65% بينما تنخفض نسبة الاناث عنها لتصل الي 35% .

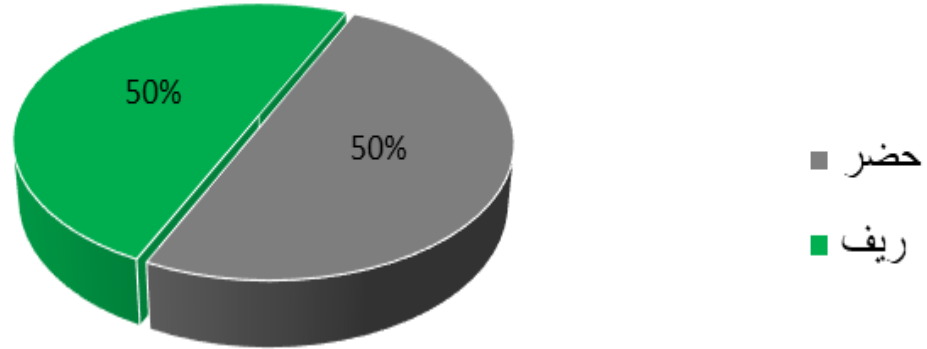
شكل رقم (2)



أظهرت نتائج الدراسة كما يوضح الشكل رقم (2) أن حوالي 42.5% من اجمالي عينة الدراسة كانوا في الفئة العمرية (30:39) بينما يليها الفئة العمرية (50 فأكثر) بحوالي نسبة 25% و يليها الفئة العمرية (40:49) بنسبة 22.5% ثم الفئة العمرية (20:29) بنسبة 10% من اجمالي عينة الدراسة .

الشكل رقم (3)

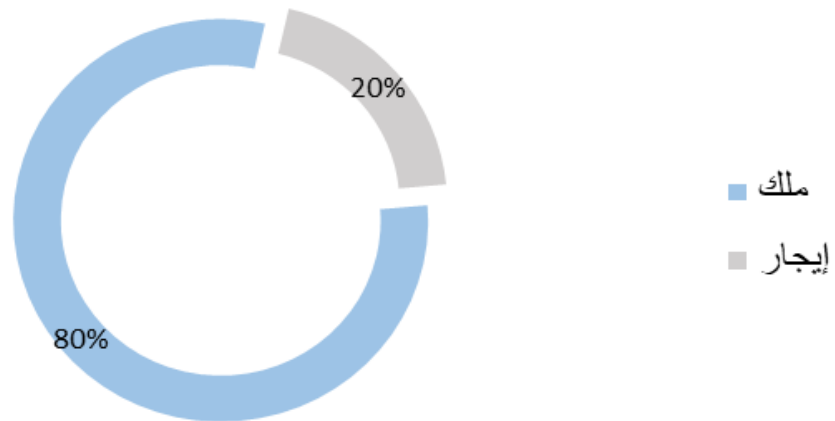
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمحل الإقامة



أبانت الدراسة كما هو موضح في الشكل رقم (3) تساوي التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب محل الإقامة حيث بلغت نسبة سكان الحضر 50% من إجمالي عينة الدراسة وكذلك أيضاً سكان الريف بنسبة 50% من إجمالي عينة الدراسة.

الشكل رقم (4)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لنوع المسكن



يوضح الشكل رقم (4) التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً لنوع المسكن حيث كانت النسبة الأكبر من نصيب الأفراد الذين يسكنون في منزل أو شقة ملك بنسبة 80% بينما في المقابل كانت النسبة الأقل من نصيب الأفراد الذين يسكنون في شقة أو منزل إيجار بنسبة 20% من إجمالي عينة البحث .

شكل رقم (5)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للحالة الاجتماعية

النسبة المئوية	التكرارات	الحالة الاجتماعية
92.5%	37	متزوج/ة
7.5%	3	مطلق/ة
0.0%	0	أرمل/ة
100.0%	40	المجموع

يبين الشكل رقم (5) التوزيع النسبي لعينة الدراسة طبقاً للحالة الاجتماعية للمبحوث حيث توضح النتائج أن النسبة الأكبر كانت من نصيب المتزوجين بنسبة 92.5% من إجمالي عينة البحث و يليها المطلقين بنسبة 7.5% من إجمالي عينة الدراسة بينما لم يشارك أي من الارامل ضمن عينة البحث .

شكل رقم (6)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب نوع التعليم

النسبة المئوية	التكرارات	نوع التعليم
40%	16	متوسط
10%	4	فوق متوسط
30%	12	تعليم جامعي
20%	8	فوق جامعي
100%	40	المجموع

يوضح الشكل رقم (6) التوزيع النسبي لعينة البحث حسب نوع التعليم عند المبحوثين حيث بلغت نسبة المتعلمين تعليم متوسط 40% من إجمالي عينة البحث و هم اكبر فئة في عينة البحث يليها المتعلمين تعليم جامعي حيث بلغت نسبتهم 30% في حين المتعلمين تعليم فوق جامعي بلغت نسبتهم 20% بينما كانت النسبة الاقل من نصيب المتعلمين تعليم فوق متوسط حيث بلغت نسبتهم 10% من إجمالي عينة البحث .

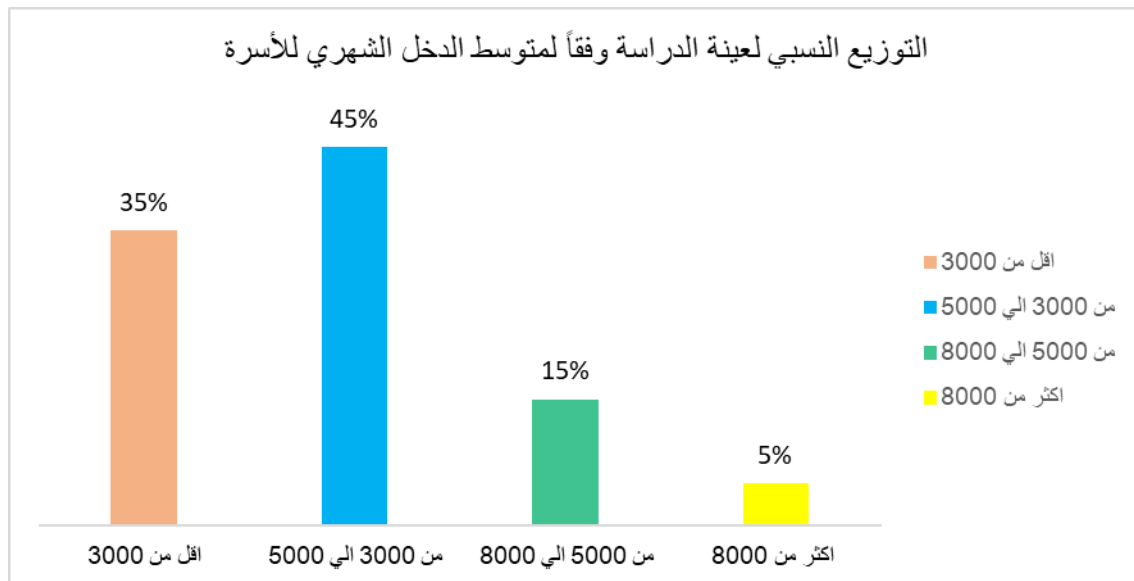
شكل رقم (7)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للدرجة الوظيفية

الدرجة الوظيفية	التكرارات	النسبة المئوية
موظف اداري	32	80%
هيئة معاونة	3	7.5%
عضو هيئة تدريس	5	12.5%
المجموع	40	100%

من الشكل رقم (7) يتضح أن الموظفين الاداريين يمثلون 80% من اجمالي عينة البحث بينما اعضاء هيئة التدريس يمثلون 12.5% و يليها اعضاء الهيئة المعاونة بنسبة 7.5% من اجمالي عينة الدراسة .

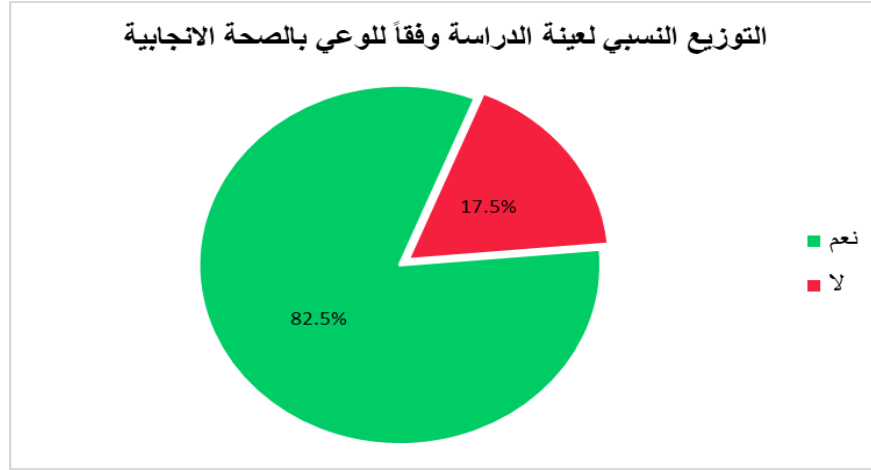
شكل رقم (8)



يمثل الشكل رقم (8) التوزيع النسبي لمتوسط الدخل الشهري للأسرة لدى المبحوثين حيث بلغت نسبة الذين دخلهم من 3000 إلى 5000 جنيه إلى 45% يليها الذين دخلهم أقل من 3000 جنيه بنسبة 35% و يليها الذين دخلهم من 5000 إلى 8000 جنيه بنسبة 15% ثم الذين دخلهم أكثر من 8000 جنيه بنسبة 5% من عينة الدراسة .

ثانيا المتغيرات المرتبطة بالصحة الانجابية

الشكل رقم (9)



يوضح الشكل رقم (9) التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً للوعي بالصحة الانجابية حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 82.5% من اجمالي عينة البحث لديهم وعي عن الصحة الانجابية بينما 17.5% من اجمالي عينة البحث ليس لديهم وعي عن الصحة الانجابية من اجمالي عينة الدراسة .

شكل رقم (10)

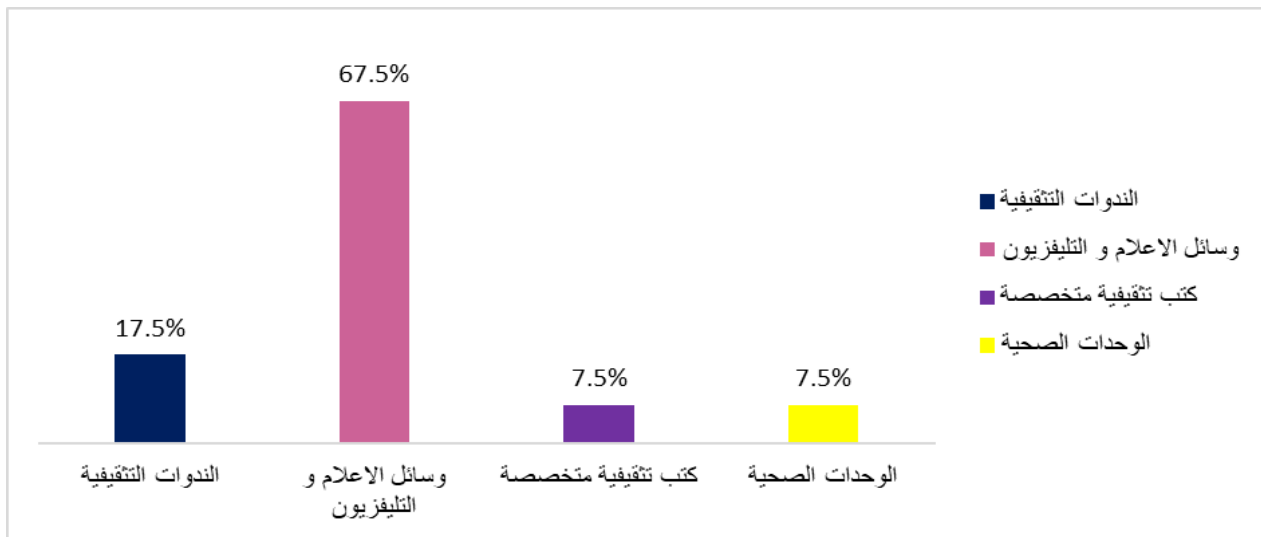
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتعريف الصحة الانجابية عند المبحوث

النسبة المئوية	التكرارات	مفهوم الصحة الانجابية
20%	8	القدرة علي الانجاب
0%	0	سلامة الجهاز التناسلي من الامراض
10%	4	إعداد المرأة للزواج
2.5%	1	التغذية السليمة
5%	2	استخدام وسائل تنظيم الاسرة
62.5%	25	كل ما سبق
100%	40	المجموع

يظهر الشكل رقم (10) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتعريف الصحة الانجابية عند المبحوث حيث كانت الانسبة الاكبر من نصيب الذين أجابو (كل ما سبق) بنسبة 62.5% من اجمالي عينة البحث و يليها الذين أجابو (القدرة علي الانجاب) بنسبة 20% و يليها الذين أجابو (إعداد المرأة للزواج) بنسبة 10% و يليها الذين أجابو (استخدام وسائل تنظيم الاسرة) بنسبة 5% و يليها الذين أجابو (التغذية السليمة) بنسبة 2.5% و اخيراً لم يجب أحد (سلامة الجهاز التناسلي من الامراض) من عينة الدراسة.

شكل رقم (11)

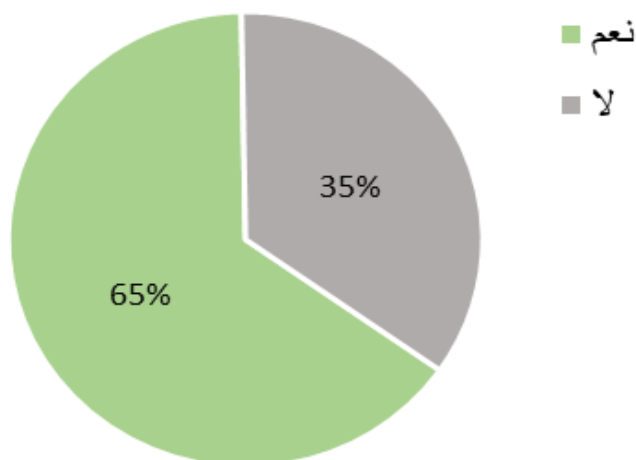
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمصدر تحصيل البيانات حول الصحة الانجابية



يوضح الشكل رقم (11) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمصدر تحصيل البيانات حول الصحة الانجابية لدى المبحوثين ووجد أن 67.5% من عينة البحث قد تلقت معلومات حول الصحة الانجابية من وسائل الاعلام والتلفزيون بينما 17.5% من عينة البحث تلقت معلومات حول الصحة الانجابية من الندوات التثقيفية و هناك 7.5% من عينة الدراسة تلقت معلومات حول الصحة الانجابية من كتب تثقيفية متخصصة و بالمثل هناك 7.5% من عينة البحث تلقت معلومات حول الصحة الانجابية من الوحدات الصحية .

شكل رقم (12)

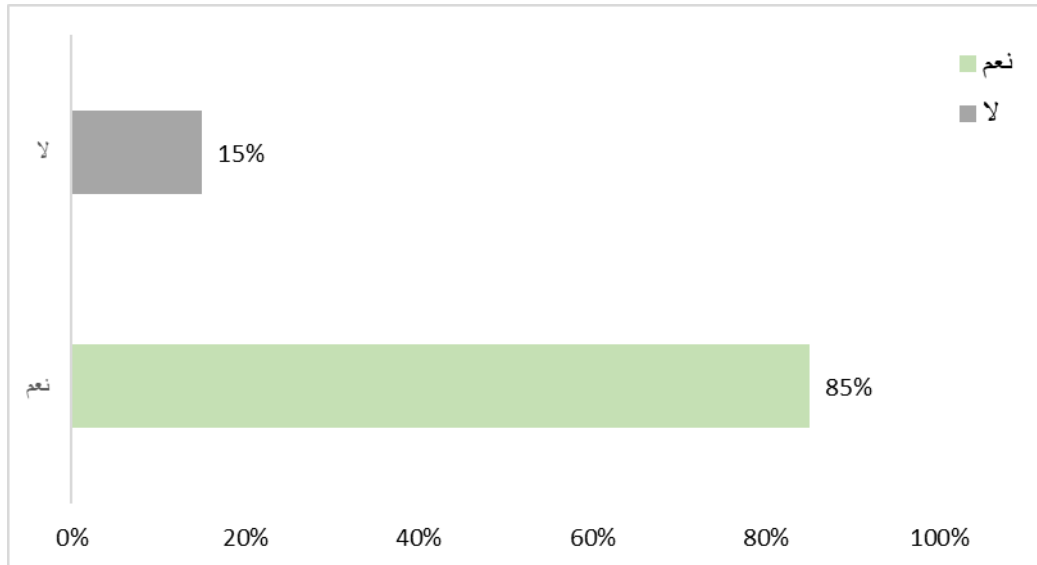
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لوعيهم بخدمات الصحة الانجابية التي تقدمها وزارة الصحة



يوضح الشكل رقم (12) التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً لوعي المبحوثين بخدمات الصحة الانجابية التي تقدمها وزارة الصحة حيث بلغت نسبة الذين لديهم وعي بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة 65% من اجمالي عينة البحث بينما هناك 35% لم يكن لديهم علم بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة .

شكل رقم (13)

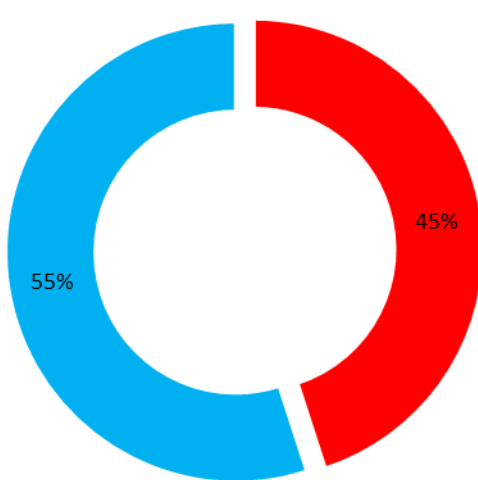
التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً للعلاقة بين مستوى التعليم و تشكيل الوعي بالصحة الانجابية



وفقاً لنتائج الدراسة نستنتج من الشكل رقم (13) أن نسبة المؤيدين لارتباط تشكيل الوعي بالصحة الانجابية بمستوي التعليم 85% من اجمالي عينة البحث بينما هناك 15% معارضين لارتباط تشكيل الوعي بالصحة الانجابية بمستوي التعليم .

شكل رقم (14)

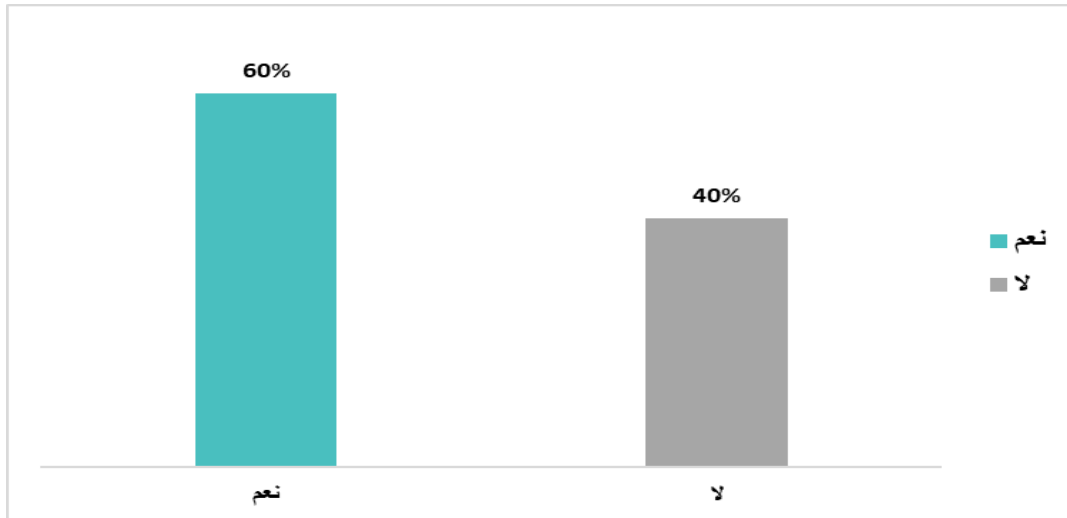
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لوجود صعوبات في تلقي خدمات الصحة الانجابية



أظهرت نتائج الدراسة وفقاً للشكل رقم (14) أن نسبة المبحوثين الذين يواجهون صعوبات في تلقي خدمات الصحة الانجابية 55% من اجمالي عينة الدراسة و علي صعيد اخر كانت نسبة المبحوثين الذين لم يواجهو اي صعوبات في تلقي خدمات الصحة الانجابية 45% من مجمل عينة الدراسة .

شكل رقم (15)

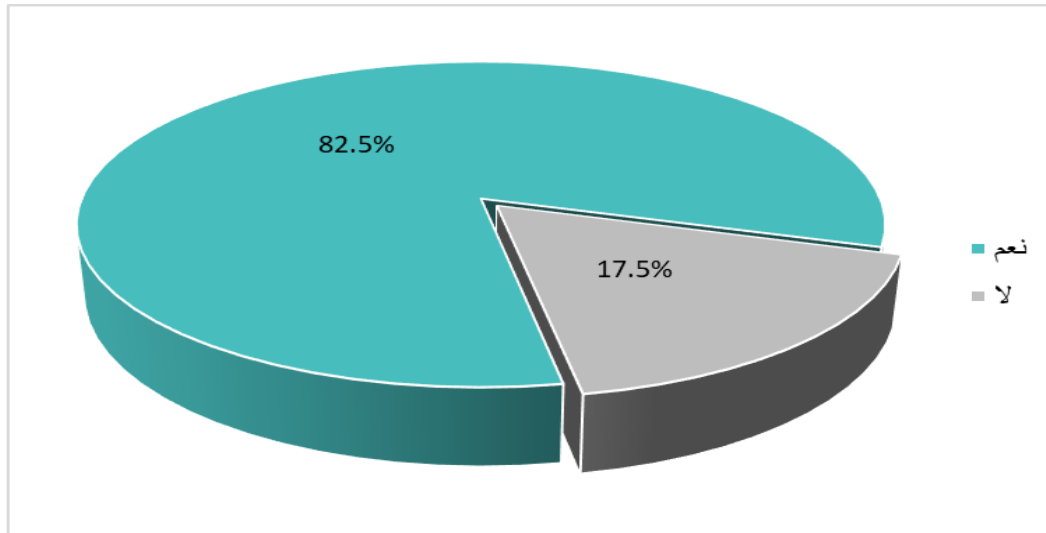
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتمثيل العادات و التقاليد عائق في تلقي خدمات الصحة الانجابية



يوضح الشكل رقم (15) التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً لتمثيل العادات و التقاليد عائقاً في تلقي خدمات الصحة الانجابية حيث وجد أن هناك 60% من اجمالي عينة الدراسة كانت العادات و التقاليد تمثل عائق لهم في تلقي خدمات الصحة الانجابية بينما هناك 40% من اجمالي عينة الدراسة لم تكن العادات و التقاليد تمثل لهم اي عائق في تلقي خدمات الصحة الانجابية .

شكل رقم (16)

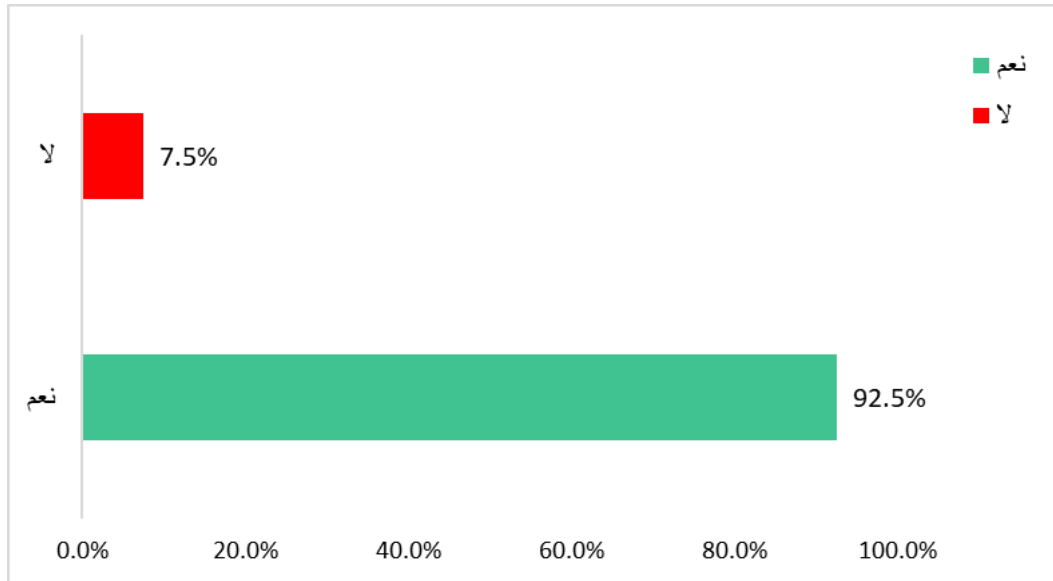
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لاختلاف مستوى الوعي بين الذكور و الاناث



وفقاً لنتائج الدراسة كما هو موضح في الشكل رقم (16) وجد أن هناك 82.5% من اجمالي عينة الدراسة يرون أن هناك اخلاف في مستوى الوعي بين الذكور و الاناث بينما هناك 17.5% من اجمالي عينة الدراسة لا يرون أن هناك اختلاف في مستوى الوعي بين الذكور و الاناث .

الشكل رقم (17)

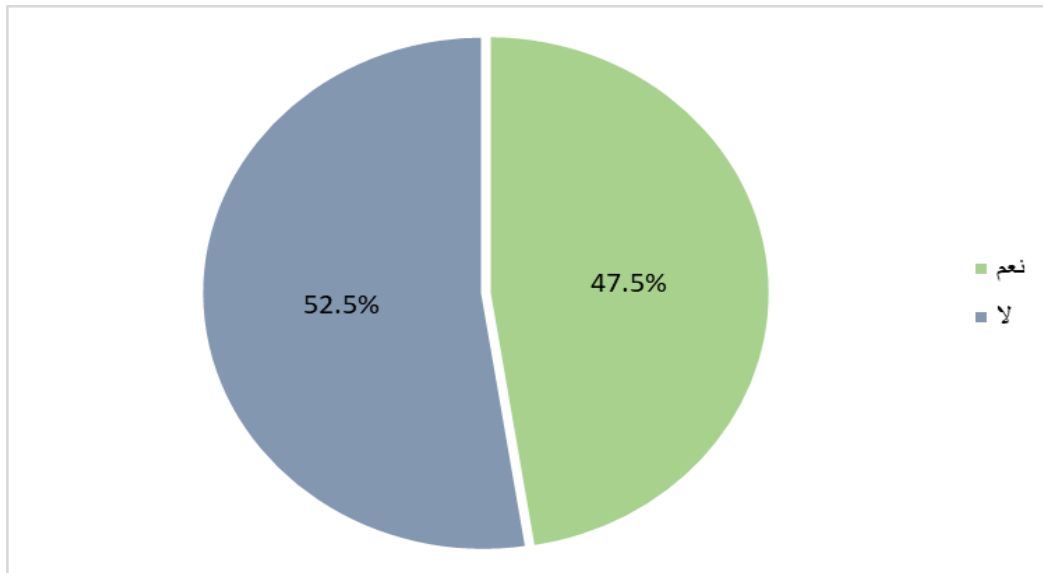
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمدي وعي المبحوثين بوجود فحص طبي قبل الزواج



أوضحت الدراسة أن 92.5% من إجمالي عينة البحث لديهم علم بوجود فحص طبي قبل الزواج بينما هناك 7.5% من إجمالي عينة البحث ليست لديهم أي فكرة بوجود فحص طبي قبل الزواج .

شكل رقم (18)

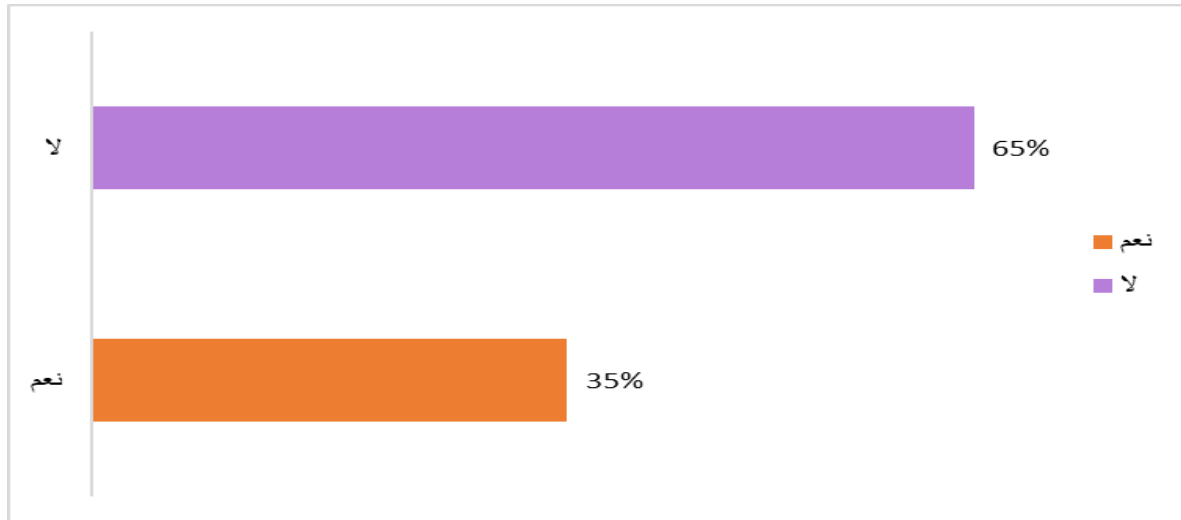
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للفحوصات الطبية الفعلية قبل الزواج



أظهرت نتائج الدراسة كما هو موضح في الشكل رقم (18) أن هناك 52.5% من إجمالي عينة الدراسة لم يقوموا بعمل فحوصات طبية قبل الزواج بينما 47.5% من إجمالي عينة الدراسة قاموا بعمل فحوصات طبية قبل الزواج .

شكل رقم (19)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتأييد المبحوثين للزواج المبكر



أوضحت نتائج الدراسة كما في الشكل رقم (19) أن نسبة المؤيدين للزواج المبكر 65% من إجمالي عينة الدراسة بينما 35% من إجمالي عينة الدراسة لا يؤيدون الزواج المبكر .

شكل رقم (20)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للسن المناسب للزواج عند الذكور

النسبة المئوية	التكرارات	السن المناسب للزواج عند الذكور
7.5%	3	أقل من 20
75%	30	من 21 إلى 29
17.5%	7	30 فأكثر
100%	40	المجموع

أبانت الدراسة أن 75% من عينة الدراسة يؤيدون الفئة العمرية (من 21 إلى 29) ويليهما الفئة العمرية (30 فأكثر) بنسبة 17.5% ويليهما الفئة العمرية (أقل من 20) بنسبة 7.5% من إجمالي عينة الدراسة .

شكل رقم (21)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للسن المناسب للزواج عند الاناث

النسبة المئوية	التكرارات	السن المناسب للزواج عند الاناث
25%	10	أقل من 20
72.5%	29	من 21 إلى 29
2.5%	1	30 فأكثر
100%	40	المجموع

أبانت الدراسة أن 72.5% من عينة الدراسة يؤيدون الفئة العمرية (من 21 إلى 29) ويلبها الفئة العمرية (أقل من 20) بنسبة 25% ويلبها الفئة العمرية (30 فأكثر) بنسبة 2.5% من اجمالي عينة الدراسة .

شكل رقم (22)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعمر المبحوثين عند الزواج

النسبة المئوية	التكرارات	العمر عند الزواج
10%	4	أقل من 20
42.5%	17	من 21 إلى 25
37.5%	15	من 26 إلى 30
10%	4	أكبر من 30
100%	40	المجموع

أوضحت الدراسة كما في الشكل رقم (22) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعمر المبحوثين عند الزواج حيث كان النصيب الأكبر للفئة العمرية (من 21 إلى 25) بنسبة 42.5% من اجمالي عينة البحث ويلبها الفئة العمرية (من 26 إلى 30) بنسبة 37.5% و يلبها الفئة العمرية (أقل من 20) بنسبة 10% و بالمثل الفئة العمرية (أكبر من 30) بنسبة 10% من اجمالي عينة البحث .

شكل رقم (23)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعدد الاطفال عند المبحوثين

عدد الاطفال	التكرارات	النسبة المئوية
لا يوجد	1	2.5%
1	5	12.5%
2	10	25%
3 فأكثر	24	60%
المجموع	40	100%

أظهرت الدراسة كما في الشكل رقم (23) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعدد الاطفال عند المبحوثين حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين أنجبوا (3 فأكثر) 60% من اجمالي عينة البحث و يليها المبحوثين الذين أنجبوا (2) بنسبة 25% ويليها المبحوثين الذين أنجبوا (1) بنسبة 12.5% ثم المبحوثين الذين لم يقوموا بانجاب اطفال بنسبة 2.5% من اجمالي عينة الدراسة .

شكل رقم (24)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعدد الاطفال المناسب للأسرة من وجهة نظر المبحوث

عدد الاطفال المناسب للأسرة	التكرارات	النسبة المئوية
1	1	2.5%
2	22	55%
3 فأكثر	17	42.5%
المجموع	40	100%

أظهرت الدراسة كما في الشكل رقم (24) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لعدد الاطفال المناسب للأسرة من وجهة نظر المبحوث حيث كانت النسبة الاكبر من نصيب المبحوثين الذين يرون أن عدد الاطفال المناسب للأسرة هو (2) بنسبة 55% من اجمالي عينة البحث ويليها الذين يرون أن (3 فأكثر) هو العدد المناسب للأسرة بنسبة 42.5% بينما الذين يرون عدد الاطفال المناسب هو (1) بنسبة 2.5% من اجمالي عينة البحث .

شكل رقم (25)

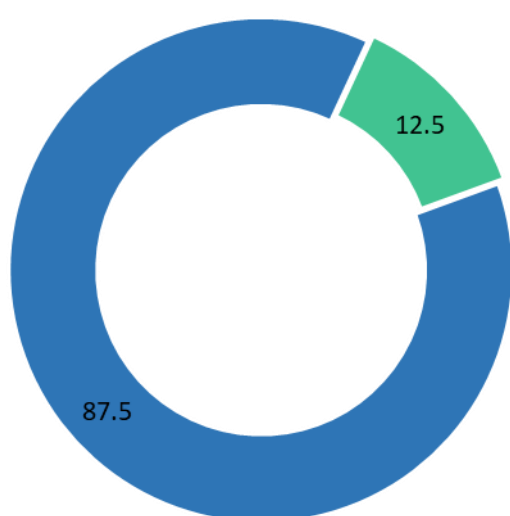
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للسن المناسب للانجاب

النسبة المئوية	التكرارات	السن المناسب للانجاب
2.5%	1	20 فأقل
55%	22	من 21 الي 25
40%	16	من 26 الي 30
2.5%	1	أكثر من 30
100%	40	المجموع

أظهرت نتائج الدراسة كما في الشكل رقم (25) التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً للسن المناسب للانجاب عند المبحوثين حيث كانت نسبة المبحوثين الذين أجمعوا علي أن الفئة العمرية (من 21 إلي 25) هي المناسبة للانجاب كانت 55% من اجمالي عينة البحث و يليها الفئة العمرية (من 26 إلي 30) بنسبة 40% و يليها الفئة العمرية (20 فأقل) بنسبة 2.5% و بالمثل الفئة العمرية (أكثر من 30) بنسبة 2.5% من اجمالي عينة الاصل .

شكل رقم (26)

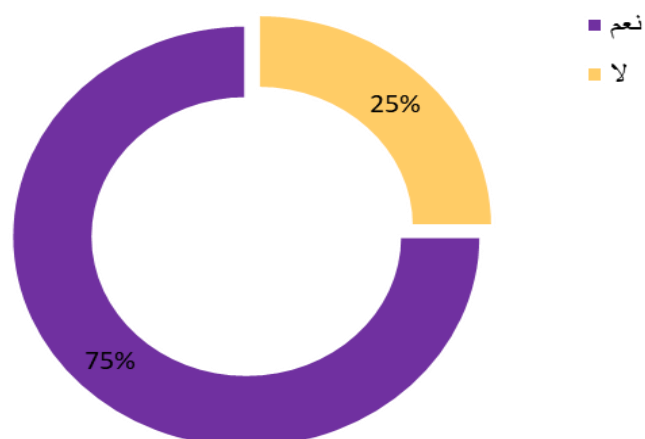
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لتأييد استخدام وسائل تنظيم الاسرة



أبانت نتائج الدراسة كما في الشكل رقم (26) أن نسبة الوُيدين لاستخدام وسائل تنظيم الاسرة كانت نسبتهم 87.5% من اجمالي عينة البحث بينما كانت نسبة المعارضين لاستخدام وسائل تنظيم الاسرة 12.5% من اجمالي عينة البحث.

شكل رقم (27)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الأسرة



أبانت الدراسة كما هو موضح في الشكل رقم (27) أن نسبة المبحوثين الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة كانت 75% من إجمالي عينة الدراسة بينما الذين لا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة بلغت نسبتهم 25% من إجمالي عينة الدراسة .

شكل رقم (28)

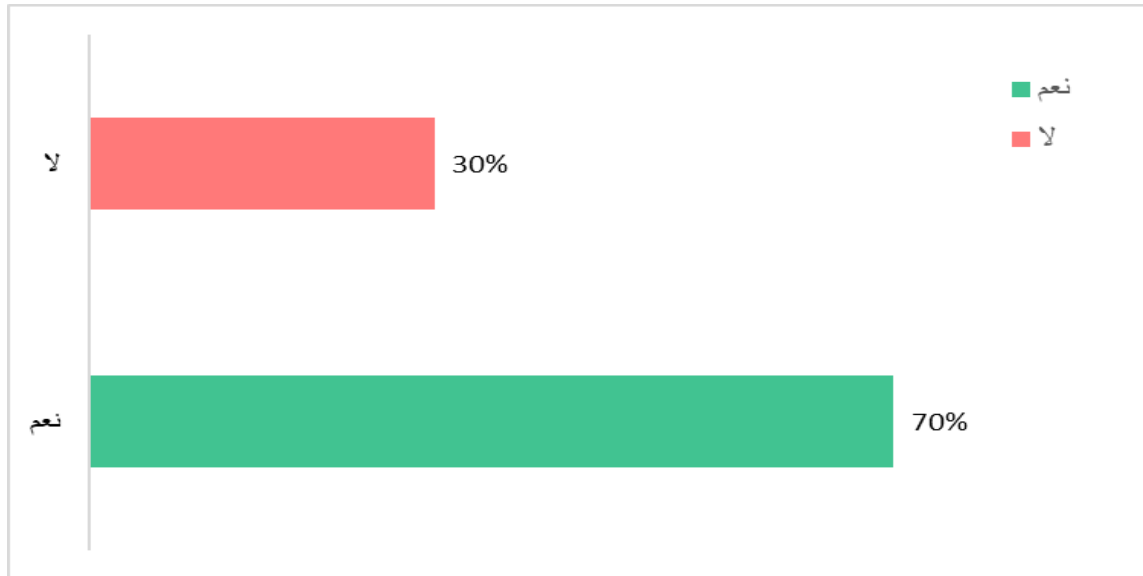
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لقرار تنظيم الأسرة

النسبة المئوية	التكرارات	قرار تنظيم الأسرة
10%	4	قرار الزوج
7.5%	3	قرار الزوجة
82.5%	33	قرار مشترك
100%	40	المجموع

أوضحت الدراسة كما في الشكل رقم (28) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لقرار تنظيم الأسرة حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين أجمعوا على أن قرار تنظيم الأسرة (قرار مشترك) 82.5% من إجمالي عينة الدراسة ويليهما المبحوثين الذين أجمعوا على أن قرار تنظيم الأسرة (قرار الزوج) بلغت نسبتهم 10% من إجمالي عينة الدراسة و يليهما المبحوثين الذين أجمعوا على أن قرار تنظيم الأسرة (قرار الزوجة) بلغت نسبتهم 7.5% من إجمالي عينة الدراسة .

شكل رقم (29)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للوعي بالأمراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل

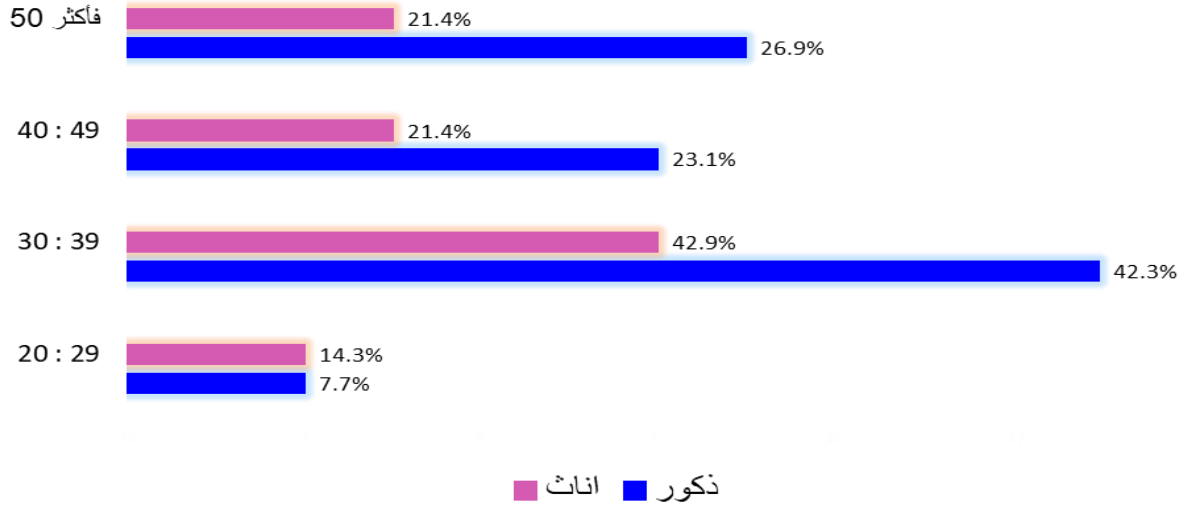


أظهرت الدراسة كما هو موضح في الشكل رقم (29) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للوعي بالأمراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين لديهم علم بالأمراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل 70% من إجمالي عينة الدراسة بينما بلغت نسبة المبحوثين الذين ليس لديهم علم بالأمراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل 30% من إجمالي عينة الدراسة .

الجدول و الشكال البيانية لبعض المتغيرات المركبة

شكل رقم (1)

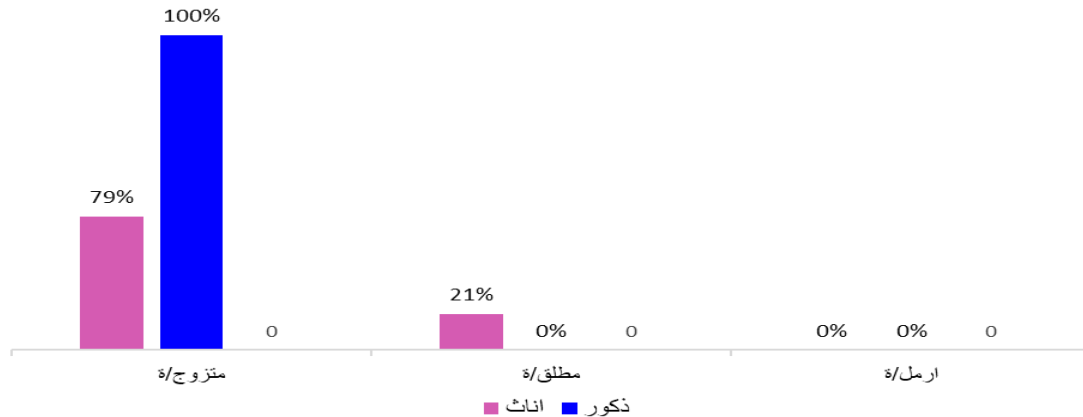
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للنوع و الفئة العمرية



توضح بيانات الشكل المقابل رقم (2) التوزيع العمري بالنسبة للنوع للعاملين بجامعة المنيا في السن (20 : +50) محل عينة الدراسة حيث يشير بيانات الشكل الي ان الفئة العمرية (30-39) تمثل 43% من اجمالي العينة حيث تمثل الذكور 42.3% من اجمالي الذكور و الاناث 42.9% من اجمالي الاناث بينما الفئة العمرية +50 تمثل 25% من اجمالي العينة حيث الذكور 26.9% من اجمالي الذكور والاناث 21.4% من اجمالي الاناث ويليهما الفئة العمرية (40-49) تمثل 23% من عينة البحث حيث بلغت نسبة الذكور 23.1% من اجمالي الذكور و نسبة الاناث 21.4% من اجمالي الاناث ويليهما الفئة العمرية من (20-29) بلغت النسبة 10% من اجمالي العينة وكانت نسبة الذكور 7.7% من اجمالي الذكور في عينة الدراسة بينما كانت نسبة الاناث 14.3% من اجمالي اناث عينة الدراسة .

شكل رقم (2)

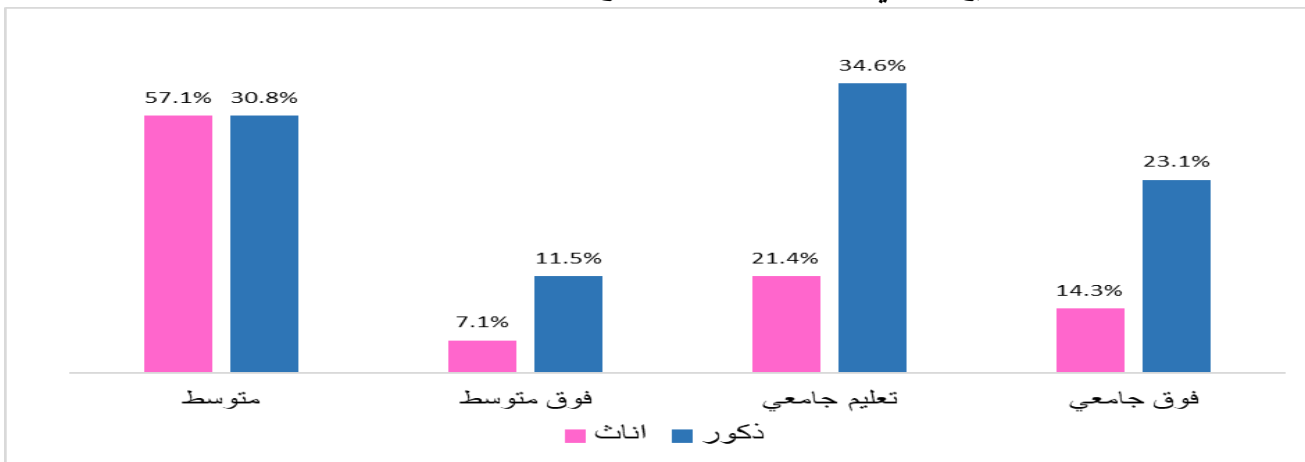
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للنوع و الحالة الاجتماعية



يوضح الشكل رقم (4) توزيع الحالة الاجتماعية بالنسبة للنوع حيث كانت النسبة الأكبر من نصيب المتزوجين حيث بلغت نسبتهم 92.5% و كان عدد الذكور المتزوجين 26 ويمثلو 100% من اجمالي ذكور عينة الدراسة و كان عدد الاناث 11 بنسبة 79% من اجمالي اناث عينة البحث و يليها المطلقين حيث بلغت نسبتهم 7.5% من اجمالي عينة البحث حيث كل المطلقين اناث بينما لم يوجد أرامل ضمن عينة الدراسة.

شكل رقم (3)

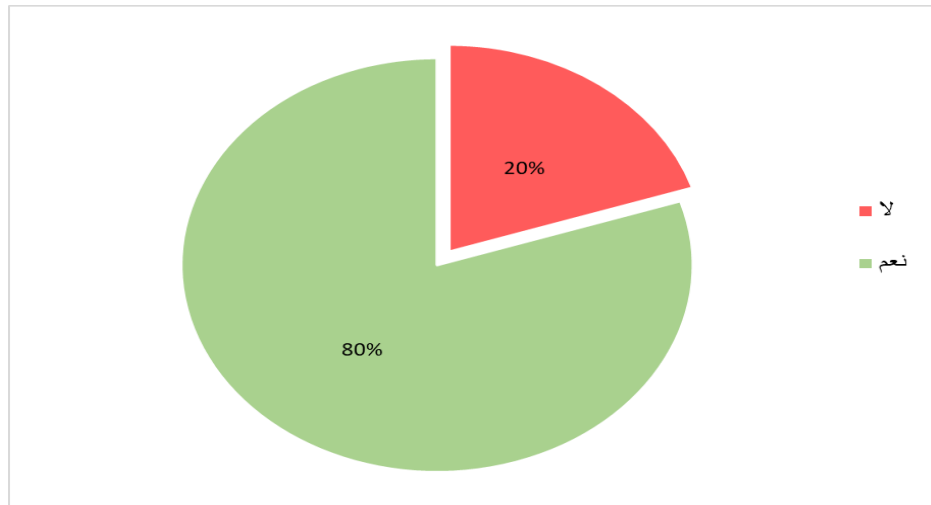
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للنوع و الحالة التعليمية



يوضح الشكل رقم (3) توزيع الحالة التعليمية بالنسبة للنوع حيث كانت النسبة الأكبر من نصيب التعليم المتوسط حيث بلغت نسبتهم 40% حيث كان عدد الذكور 8 و كانت نسبتهم 30.8% من اجمالي ذكور الدراسة و عد الاناث 8 و كانت نسبتهم 57.1% من اجمالي اناث الدراسة و يليها التعليم الجامعي حيث بلغت نسبتهم 30% و كان عدد الذكور 9 وكانت نسبتهم 34.6% من اجمالي ذكور الدراسة و عدد الاناث 3 و كانت نسبتهم 21.4% من اجمالي اناث الدراسة و يليها التعليم فوق جامعي حيث بلغت نسبتهم 20% و كان عدد الذكور 6 وكانت نسبتهم 23.1% من اجمالي ذكور الدراسة و عدد الاناث 2 و كانت نسبتهم 14.3% من اجمالي اناث الدراسة و يليها التعليم فوق متوسط حيث بلغت نسبتهم 10% حيث بلغ عدد الذكور 3 و بلغت نسبتهم 11.5% من اجمالي ذكور الدراسة عدد الاناث 1 و كانت نسبتهم 7.1% من اجمالي اناث الدراسة .

شكل رقم (4)

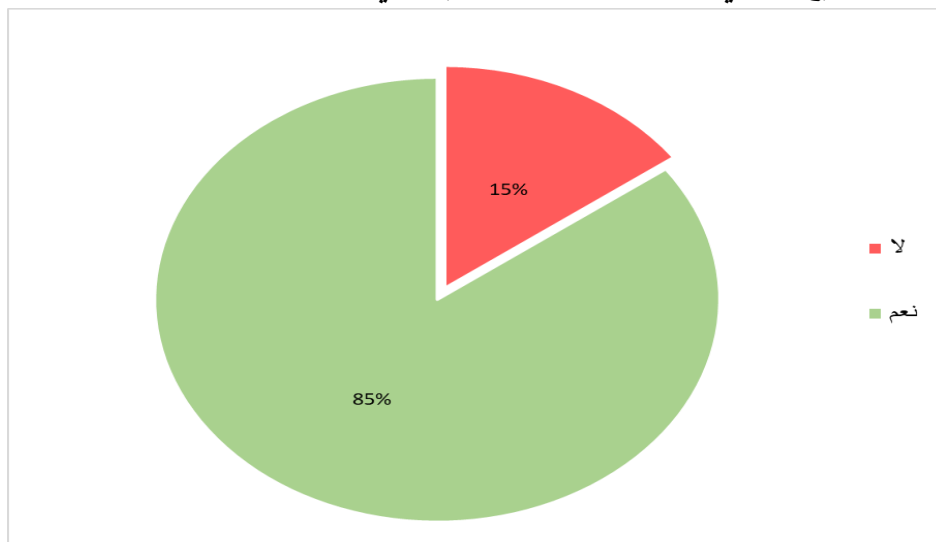
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمدي وعي العاملين بالكلية النظرية



يوضح الشكل رقم (4) التوزيع النسبي للوعي بالصحة الانجابية لدي العاملين بالكلية النظرية حيث بلغت نسبة الذين عندهم وعي بالصحة الانجابية 80% من اجمالي عينة البحث التي تمت داخل الكلية النظرية بينما الذين ليس لديهم وعي بالصحة الانجابية 20% من اجمالي عينة البحث التي تمت داخل الكلية النظرية .

شكل رقم (5)

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمدي وعي العاملين بالكلية التطبيقية



يوضح الشكل رقم (5) التوزيع النسبي للوعي بالصحة الانجابية لدي العاملين بالكلية التطبيقية حيث بلغت نسبة الذين عندهم وعي بالصحة الانجابية 85% من اجمالي عينة البحث التي تمت داخل الكلية التطبيقية بينما الذين ليس لديهم وعي بالصحة الانجابية 15% من اجمالي عينة البحث التي تمت داخل الكلية التطبيقية .

التعليق على الجداول المركبة من واقع بيانات Spss 28.

اختبار كاي للاستقلالية بين الدرجة الوظيفية و الوعي بالصحة الانجابية لدى عينة الدراسة

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.121 ^a	2	0.346

يوضح الجدول الحالي نتائج اختبار كاي للاستقلالية عدم وجود علاقة بين الدرجة الوظيفية و الوعي بالصحة الانجابية حيث بلغت قيمة الدلالة العلمية 0.346 و هي أكبر من 0.05 , و بناء علي هذه النتائج فأنا نقبل الفرض الصفري الذي ينص علي عدم وجود علاقة بين المتغيرين .

اختبار التباين بين الحالة التعليمية و الوعي بالصحة الانجابية لدى عينة الدراسة

ANOVA

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.671	3	0.224	1.577	0.212

أثبت الجدول الحالي لاختبار التباين بين الحالة التعليمية و الوعي بالصحة الانجابية عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المتغيرين حيث بلغت قيمة الدلالة العلمية 0.212 و هي أكبر من 0.05 و بالاستناد إلي البيانات الحالية نقبل الفرضية الصفرية التي تنص علي عدم وجود فروق بين ذات دلالة احصائية بين المتغيرات .

نتائج الدراسة

- 1- ترتفع نسبة الوعي بقضايا الصحة الانجابية لدى العاملين بجامعة المنيا بمتوسط 82.5% من اجمالي العاملين .
- 2- ترتفع نسبة الوعي بقضايا الصحة الانجابية بالكليات التطبيقية بصورة طفيفة مقارنة بالكليات النظرية حيث بلغت نسبة الوعي بموضوعات الصحة الانجابية نحو 85% من اجمالي عينة الكليات التطبيقية في حين بلغت نحو 80% من الكليات النظرية .
- 3- أوضحت الدراسة أن وسائل الاعلام و التلفزيون تساهم في تحصيل المعلومات عن الصحة الانجابية بنسبة 67.5% .
- 4- تمثل العادات و التقاليد عائق في تلقي خدمات الصحة الإنجابية و ذلك بنسبة 60% .
- 5- نسبة 97.5% يقرون أن الوعي بخدمات الصحة الإنجابية يساعد في الوقاية من الامراض.
- 6- اظهرت النتائج أن 42.5% من اجمالي عينة البحث تزوجو في الفئة العمرية (21 : 25).
- 7- اظهرت الدراسة أن نسبة 65% من العينة لا تؤيد الزواج المبكر.
- 8- اوضحت الدراسة أن نسبة 75% من العينة ترى أن السن المناسب للزواج لدى الذكور في الفئة العمرية بين (21-29) ، بينما رأت نسبة 72.5% أن هذا السن المناسب لزوج الإناث أيضا.
- 9- أشارت نسبة 55% من عينة الدراسة أن العدد المناسب من الأطفال 2 فقط.
- 10- أيد 87.5% من العينة استخدام وسائل تنظيم الاسرة ،و نسبة 75% منهم يستخدمونها بالفعل.
- 11- كما اوضحت الدراسة أن نسبة 97.5 يؤيدون أهمية فترة المباحثات بين فترات الحمل
- 12-ترتفع نسبة الوعي بالصحة الانجابية عند الذكور عن الاناث حيث وصلت نسبة الوعي عند الذكور 88.5% بينما كانت نسبة الوعي عند الاناث 71.4% .
- 13- توضح الدراسة أن هناك علاقة بين مستوى الوعي و السلوك الإنجابي لدى العاملين بجامعة المنيا.

التوصيات

- 1- تشجيع منظمات المجتمع المدني علي تنظيم حملات و قوافل توعوية للصحة الانجابية.
- 2- تشجيع دور الرائدات و المثقفات الصحيات لتشمل القطاع التربوي و الجامعي.
- 3- تشجيع منظمات المجتمع المدني علي تقديم الخدمات الصحيه بالمناطق الاكثر احتياجاً ، و ذلك وفقاً لخريطة اولويات التدخل لكل محافظة،من خلال التنسيق مع وزارة الصحة و السكان طبقاً لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة.
- 4- توحيد معايير تقديم الخدمات الطبية المتنقلة بين منظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الصحية العامه و تنظيم الأسرة و الاكتشاف المبكر للاورام و للاعاقة وفقاً لمعايير وزارة الصحة.
- 5- تأهيل بناء قدرات الكوادر الطبية و المهنية من خلال تنفيذ برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني فى مجالات التخطيط الصحي و المتابعه و التقييم و تنفيذ البحوث.
- 6- إعداد دليل عمل مرجعي للتواصل الفعال مع المجتمع ،متضمناً كل الرسائل الصحية الاساسية المعتمده من وزارة الصحة و السكان ، و تعميمها على كافة العاملين الميدانيين المعنيين.
- 7- تشجيع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ حملات اعلامية للدعوى لكسب التأييد لقضايا الصحة العامة و الصحة الإنجابية و تنظيم الاسرة على المستوى المحلى.
- 8- إنشاء قاعدة بيانات عن خدمات الصحة الإنجابية و ذلك لنشر الوعى بطريقة أوسع و أشمل على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
- 9- التوسع فى إدخال خدمات الصحة الإنجابية للمراكز الصحية و ذلك لسهولة الحصول على الخدمات بشكل أسرع.
- 10- تشجيع و تفعيل دور الرائدات الريفيات و تدريبهن على تقديم خدمه التثقيفيه بجودة عالية تتضمن رفع درجة الوعى لمتلقي الخدمة.
- 11- تفعيل دور الاعلام السكاني بالكليات النظرية بصورة اكبر .

قائمة المراجع

- عبد المجيد احمد هندي ، الوعي السكاني و المسؤولية الانجابية : دراسة ميدانية مقارنة عبر الاجيال في المجتمع الريفي ، مجلة البحث العلمي في الاداب يوليو 2022 ، ع23 ، ج6
- عائشة شعبان ، الوعي بثقافة الصحة الانجابية في الاسرة المصرية دراسة ميدانية بمدينة أسيوط ، المجلة العلمية لكلية الاداب ، ملحق العدد 79 ، يوليو 2021م
- ايمان علي الهادي الخفاجي ، الوعي المجتمعي بالصحة الانجابية ، Research gate ، 2019 ، جامعة بغداد ،
- احمد سيد خليل ؛ راضي عبد المجيد طه ؛ الوعي السكاني لدي طلاب كلية التربية جامعة اسوان ؛ دراسة ميدانية ؛ جامعة طنطا، عام 1999
- عبد المعين سعد الدين هندي ، دور التعليم في تنميه الوعي بالصحة الانجابية لدى المرأة بصعيد مصر دراسته ميدانية ، المجلة التربوية ، ع ٢١ ، يناير ٢٠٠٥م
- نجوى عبد الرحمن حسن، دراسة مقارنة لمحددات السلوك الانجابي للريفات بمحافظة المنوفية واسيوط، جامعه المنوفية، 2007
- ايمان محمد الصياد، المحددات الاجتماعية للسلوك الانجابي للمرأة الريفية دراسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، جامعه عين شمس، م(٤٥)، ٢٠١٧
- أمل ابراهيم عبده، وعي الشباب الجامعي بقضايا الصحة الإنجابية، الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين، يونيو 2018، عدد 60، ص 137_188
- عائشة شعبان ، الوعي بثقافة الصحة الانجابية في الأسرة المصرية دراسة ميدانية بمدينة أسيوط ، المظلة العلمية لكلية الآداب ، ملحق العدد ٧٩ ، يوليو ٢٠٢١م
- نجلاء محمد احمد عبد الرحمن ، المتغيرات السوسيوثقافية اقتصادية بيئية المؤثرة في الصحة الانجابية للمرأة دراسة مقارنة بين منطقة عشوائية واخرى حضرية ،مجلة كلية الآداب ، ع(٦٤) ، ج (٢) ٢٠٢٢م ..
- محمد محمود عيسى ابو زنيد ، مفاهيم ومواقف طلاب جامعه النجاح الوطنية في مواضيع الصحة الانجابية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، فلسطين ، ٢٠٠٦م
- أحمد بن عبد المجيد بن علي ابو الحمائل - ضياء الدين مطاوع - وواد نور الدين ، فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي بالصحة الإنجابية لدى طلاب جامعة الملك عبد العزيز ، مستقبل التربية العربية ، مج (١٧) ، ع (٦٧) ، ٢٠١٠م

- فهد الصبري _ سمية صالح ،قياس وعي الشباب بأهمية القضايا السكانية وتعدياتها المستقبلية ، عام 2013 ، من ص5 : ص 85 .
- الاء الطائي، الوعي بالفحص الطبي ودوره في الصحة الإنجابية دراسة ميدانية للطالبات الجمعيات المتزوجات في جامعه الشارقة، مجله جامعه الشارقة للعلوم الإنسانية الاجتماعية، م(١٦)، ٢٠١٩
- ربا السيد محمد ابو كميل،مستوى الوعي بمفاهيم الصحة الإنجابية لدي طلبة المرحلة الأساسية العليا في غزة، 2011.
- سليمان ،عائشة شعبان على إبراهيم، 20٢١،الوعى بثقافة الصحة الإنجابية في الأسرة المصرية، دراسة ميدانية بمدينة أسيوط ،المجلة العلمية لكلية الآداب، مج ٢٤



كلية الآداب
قسم الدراسات السكانية



جامعة المنيا

مسلسل ()

صحيفة استبيان بالمقابلة عن

الوعي بالصحة الإيجابية لدى العاملين بجامعة المنيا دراسة ميدانية مقارنة

إعداد

محمد منصور صابر

2023/1444م

أولاً: المتغيرات المرتبطة بالبيانات الشخصية :

1. النوع

☐ ذكر

☐ أنثى

2. العمر

☐ 20:29

☐ 30:39

☐ 40:49

☐ 50 فأكثر

3. محل الإقامة الحالي؟

☐ حضر

☐ ريف

4. نوع المسكن الحالي؟

☐ ملك

☐ إيجار

5. حاله الاجتماعية؟

☐ متزوج/ة

☐ مطلق/ة

☐ أرمل/ة

6. حاله التعليمية؟

☐ متوسط

☐ فوق المتوسط

☐ تعليم جامعي

☐ فوق الجامعي

7. الدرجة الوظيفية للمبحوث؟

- ☐ موظف إداري
- ☐ هيئة معاونة
- ☐ عضو هيئة تدريس

8. متوسط الدخل الشهري للأسرة؟

- ☐ أقل من 2999
- ☐ من 3000 إلى 4999
- ☐ من 5000 إلى 7999
- ☐ 8000 فأكثر

9. هل الدخل الشهري كافٍ لتلبية احتياجات الأسرة؟

- ☐ نعم
- ☐ لا

ثانياً : المتغيرات المرتبطة بالصحة الإنجابية :

10. هل تعلم ما هي الصحة الإنجابية ؟

- ☐ نعم
- ☐ لا

11. ماذا تعني الصحة الإنجابية حسب رأيك؟

- ☐ القدرة علي الانجاب
- ☐ سلامة الجهاز التناسلي من الامراض
- ☐ إعداد المرأة للزواج
- ☐ التغذية السليمة
- ☐ استخدام وسائل تنظيم الأسرة
- ☐ كل ما سبق

12. من اين حصلت علي معلومات حول الصحة الإنجابية ؟

- ☐ الندوات التثقيفية
- ☐ وسائل الاعلام والتلفزيون

○ كتب تثقيفية متخصصة

○ الوحدات الصحية

13. هل لديك علم بخدمات الصحة الانجابية التي تقدمها وزارة الصحة و السكان؟

○ نعم

○ لا

14. هل ترى أن هناك علاقة بين مستوي التعليم و تشكيل الوعي بالصحة الانجابية ؟

○ نعم

○ لا

15. هل تجد صعوبة في الوصول الى خدمات الصحة الانجابية؟

○ نعم

○ لا

16. هل ترى ان العادات والتقاليد تعد عائقاً في تلقي خدمات الصحة الانجابية؟

○ نعم

○ لا

17. هل ترى أن مستوي الوعي بالصحة الانجابية يختلف بين الذكور و الإناث ؟

○ نعم

○ لا

18. هل ترى ان الصحة الانجابية تساعد في الوقاية من الامراض؟

○ نعم

○ لا

19. هل تعلم بوجود فحص طبي قبل الزواج ؟

○ نعم

○ لا

20. هل قمت بعمل أي فحوصات طبية فعلية قبل الزواج؟

○ نعم

○ لا

21. هل تري أن الفحص الطبي قبل الزواج ضروري لتجنب الأمراض الوراثية و الجنسية؟

☐ نعم

☐ لا

22. هل لديك علم بمخاطر زواج الاقارب ؟

☐ نعم

☐ لا

23. هل تؤيد الزواج المبكر ؟

☐ نعم

☐ لا

24. ما هو السن المناسب للزواج عند الذكور ؟

☐ أقل من 20

☐ من 21 إلي 29

☐ 30 فأكثر

25. ما هو السن المناسب للزواج عند الإناث ؟

☐ أقل من 20

☐ من 21 إلي 29

☐ 30 فأكثر

26. كم كان عمرك عندما تزوجت ؟

☐ أقل من 20

☐ من 21 إلي 25

☐ من 26 إلي 30

☐ أكثر من 30

27. هل لديك أطفال ؟

☐ نعم

☐ لا

28. كم عدد الأطفال ؟

☐ لا يوجد

☐ 1

2 ☐
3 فأكثر ☐

29. ما هو عدد الاطفال المناسب للأسرة في رأيك ؟

لا افضل الانجاب ☐
1 ☐
2 ☐
3 فأكثر ☐

30. ما هو السن المناسب للانجاب في رأيك ؟

20 فأقل ☐
من 21 إلى 25 ☐
من 26 إلى 30 ☐
أكثر من 30 ☐

31. هل تؤيد استخدام وسائل تنظيم الاسرة ؟

نعم ☐
لا ☐

32. هل سبق و استخدمتم وسائل تنظيم الاسرة ؟

نعم ☐
لا ☐

33. لمن يرجع قرار تنظيم الاسرة ؟

قرار الزوج ☐
قرار الزوجة ☐
قرار مشترك ☐

34. هل تري أن المباشرة بين فترات الحمل مهم لصحة الام و الطفل ؟

نعم ☐
لا ☐

35. هل لديك أي فكره عن الامراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل و بعدها ؟

نعم ☐
لا ☐

36. هل قمتم بالمتابعة مع طبيب متخصص خلال فترة الحمل؟

○ نعم
○ لا

37. هل تمت الولاده تحت اشراف طبي متخصص؟

○ نعم
○ لا

38. هل حدث حمل غير مخطط و متفق عليه من قبل؟

○ نعم
○ لا

39. إذا حدث حمل غير مخطط و غير مرغوب سوف تلجأ إلي ؟

○ استكمال الحمل
○ اللجوء إلي الإجهاض

نسبة مشاركة النوع

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ذكر	26	65.0	65.0	65.0
	انثي	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

العمر

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20:29	4	10.0	10.0	10.0
	30:39	17	42.5	42.5	52.5
	40:49	9	22.5	22.5	75.0
	50 فأكثر	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

محل الإقامة

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	حضر	20	50.0	50.0	50.0
	ريف	20	50.0	50.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

نوع المسكن

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ملك	32	80.0	80.0	80.0
	إيجار	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الحالة الاجتماعية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ة/متزوج	37	92.5	92.5	92.5
	ة/مطلق	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الحالة التعليمية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	متوسط	16	40.0	40.0	40.0
	متوسط فوق	4	10.0	10.0	50.0
	جامعي تعليم	12	30.0	30.0	80.0
	جامعي فوق	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الدرجة الوظيفية للمبحوث

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	اداري موظف	32	80.0	80.0	80.0
	معاونة هيئة	3	7.5	7.5	87.5
	تدريس هيئة عضو	5	12.5	12.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

متوسط الدخل الشهري للأسرة

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3000 من اقل	14	35.0	35.0	35.0
	5000 الي 3000 من	18	45.0	45.0	80.0
	8000 الي 5000 من	6	15.0	15.0	95.0
	8000 من اكثر	2	5.0	5.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

تغطية الدخل الشهري لاحتياجات الاسرة

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	9	22.5	22.5	22.5
	لا	31	77.5	77.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الوعي بالصحة الانجابية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	33	82.5	82.5	82.5
	لا	7	17.5	17.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

مفهوم الصحة الانجابية عند المبحوث

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الانجاب علي القدرة	8	20.0	20.0	20.0
	للزواج المرأة إعداد	4	10.0	10.0	30.0
	السليمة التغذية	1	2.5	2.5	32.5
	الاسرة تنظيم وسائل استخدام	2	5.0	5.0	37.5
	سبق ما كل	25	62.5	62.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

مصدر تحصيل المعلومات حول الصحة الانجابية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	التثقيفية الندوات	7	17.5	17.5	17.5
	التلفزيون و الاعلام وسائل	27	67.5	67.5	85.0
	متخصصة تثقيفية كتب	3	7.5	7.5	92.5
	الصحية الوحدات	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

العلم بخدمات الصحة الانجابية المقدمة من وزارة الصحة و السكان

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	26	65.0	65.0	65.0
	لا	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

العلاقة بين مستوى التعليم و تشكيل الوعي بالصحة الانجابية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	34	85.0	85.0	85.0
	لا	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الصعوبة في الوصول الي خدمات الصحة الانجابية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	18	45.0	45.0	45.0
	لا	22	55.0	55.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

تمثل العادات و التقاليد عائق لتلقي خدمات الصحة الانجابية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	24	60.0	60.0	60.0
	لا	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

اختلاف مستوى الوعي بالصحة الانجابية بين الذكور و الاناث

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	33	82.5	82.5	82.5
	لا	7	17.5	17.5	100.0

Total	40	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

مساهمة الصحة الانجابية في الوقاية من الامراض

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	39	97.5	97.5	97.5
	لا	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الوعي بوجود فحص طبي قبل الزواج

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	37	92.5	92.5	92.5
	لا	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

عمل فحوصات طبية فعلية قبل الزواج

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	19	47.5	47.5	47.5
	لا	21	52.5	52.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

مساهمة الفحص الطبي في تجنب الامراض الوراثية و الجنسية

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	37	92.5	92.5	92.5
	لا	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الوعي بمخاطر زواج الاقارب

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	39	97.5	97.5	97.5

	لا	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

تأييد الزواج المبكر

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	14	35.0	35.0	35.0
	لا	26	65.0	65.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

السن المناسب للزواج عند الذكور

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 من أقل	3	7.5	7.5	7.5
	29 إلى 21 من	30	75.0	75.0	82.5
	فأكثر 30	7	17.5	17.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

السن المناسب للزواج عند الإناث

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 من أقل	10	25.0	25.0	25.0
	29 إلى 21 من	29	72.5	72.5	97.5
	فأكثر 30	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

العمر عند الزواج

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 من أقل	4	10.0	10.0	10.0
	25 إلى 21 من	17	42.5	42.5	52.5
	30 إلى 26 من	15	37.5	37.5	90.0
	30 من أكبر	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

		وجود اطفال			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	نعم	39	97.5	97.5	97.5
	لا	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

		عدد الاطفال			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	يوجد لا	1	2.5	2.5	2.5
	1	5	12.5	12.5	15.0
	2	10	25.0	25.0	40.0
	فأكثر 3	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

		عدد الاطفال المناسب للأسرة			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	1	1	2.5	2.5	2.5
	2	22	55.0	55.0	57.5
	فأكثر 3	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

		السن المناسب للانجاب			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	فأقل 20	1	2.5	2.5	2.5
	25 الي 21 من	22	55.0	55.0	57.5
	30 الي 26 من	16	40.0	40.0	97.5
	30 من أكثر	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

تأييد استخدام وسائل تنظيم الأسرة

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	35	87.5	87.5	87.5
	لا	5	12.5	12.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الأسرة

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	30	75.0	75.0	75.0
	لا	10	25.0	25.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

قرار تنظيم الأسرة

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الزوج قرار	4	10.0	10.0	10.0
	الزوجة قرار	3	7.5	7.5	17.5
	مشترك قرار	33	82.5	82.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

اهمية المبالغة بين فترات الحمل

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	39	97.5	97.5	97.5
	لا	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

العلم بالامراض التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل و بعدها

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	28	70.0	70.0	70.0

	لا	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

المتابعة مع طبيب متخصص خلال فترة الحمل

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	35	87.5	87.5	87.5
	لا	5	12.5	12.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

الولادة تحت اشراف طبي

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	35	87.5	87.5	87.5
	لا	5	12.5	12.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

حدوث حمل غير مخطط له من قبل

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	17	42.5	42.5	42.5
	لا	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

التصرف عند حدوث حمل غير مخطط له او غير مرغوب

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الحمل استكمال	38	95.0	95.0	95.0
	الإجهاض الي اللجوء	2	5.0	5.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	